



Nuansa
Fajar
Cemerlang

INTEGRASI STRATEGI MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT

LANGKAH HOLISTIK BAGI KESEHATAN BALITA

Sri Rosita • Rahmayani • Evi Dewi Yani
Yunita • Tika Indiraswari

INTEGRASI STRATEGI MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT: LANGKAH HOLISTIK BAGI KESEHATAN BALITA

Penulis:

Sri Rosita, S.KM., M.K.M.

Rahmayani, S.KM., M.Kes.

Evi Dewi Yani, S.KM., M.Kes.

Yunita, S.Pd., M.Pd.

Dr. Tika Indiraswari, S.Si., M.Kes.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

**Integrasi Strategi Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS):
Langkah Holistik Bagi Kesehatan Balita**

Penulis: Sri Rosita, S.KM., M.K.M.

Rahmayani, S.KM., M.Kes.

Evi Dewi Yani, S.KM., M.Kes.

Yunita, S.Pd., M.Pd.

Dr. Tika Indiraswari, S.Si., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7097-98-9

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN
PENANGGUNG JAWAB

Integrasi strategi manajemen terpadu balita sakit (MTBS) : langkah holistik bagi kesehatan balita / penulis, Sri Rosita, S.KM., M.K.M., Rahmayani, S.KM., M.Kes., Evi Dewi Yani, S.KM., M.Kes., Yunita, S.Pd., M.Pd., Dr. Tika Indiraswari, S.Si., M.Kes.

EDISI

Cetakan pertama, Februari 2025

PUBLIKASI

Jakarta : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025

DESKRIPSI FISIK

96 halaman ; 30 cm

IDENTIFIKASI

ISBN 978-634-7097-98-9

SUBJEK

Kesehatan bayi, Pelayanan

KLASIFIKASI

613.043 2 [23]

PERPUSNAS ID

<https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1075425>

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW karena dengan berkat dan karunia Nya lah kami bisa menyelesaikan buku ini dengan baik yang berjudul **"Integrasi Strategi Manajemen Terpadu Balita Sakit: Langkah Holistik Bagi Kesehatan Balita"**.

Salah satu masalah terbesar di bidang kesehatan global, terutama di negara berkembang, adalah kesehatan balita. Angka kematian balita yang tinggi disebabkan oleh penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, diare, malnutrisi, dan malaria. Dengan mengambil tindakan yang tepat dan terpadu, banyak kasus ini sebenarnya dapat dicegah atau ditangani. Buku ini hadir sebagai panduan lengkap terkait strategi manajemen terpadu balita sakit dengan menggabungkan hasil medis terbaru dengan pendekatan pragmatis.

Kami menyusun buku ini dengan pendekatan inovatif yang mengintegrasikan berbagai aspek baik promotif, preventif, maupun kuratif untuk meningkatkan kesehatan anak secara menyeluruh. Strategi manajemen terpadu balita sakit dalam buku ini kami kupas terkait dengan urgensi untuk menjawab kebutuhan mendesak akan pendekatan holistik yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, memberikan dampak positif pada kesehatan generasi masa depan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan global.

Kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, khususnya keluarga tercinta, rekan-rekan sejawat dan pakar kesehatan yang selalu memberikan inspirasi, masukan dan motivasi sehingga buku ini bisa terselesaikan dengan baik.

Kami juga mengucapkan terimakasih kepada penerbit yang memberikan kesempatan dan menerbitkan buku ini.

Kami berharap buku ini bermanfaat untuk khalayak umum dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terkaita bagaimna strategi manajemen terpadu balita sakit mencakup langkah pencegahan dan promosi kesehatan melalui pemberian edukasi kepada keluarga, peningkatan gizi, pemberian imunisasi, serta pengelolaan faktor lingkungan yang mendukung kesehatan balita.

Kami menyadari buku ini masih memiliki kekurangan, kami berterimakasih dengan kritikan dan saran dari pembaca untuk perbaikan di masa mendatang. Selamat membaca...

Januari, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 KONSEP KESEHATAN BALITA	9
A. Pengertian Kesehatan Balita	9
B. Pendekatan Strategis Meningkatkan Kesehatan Balita.....	10
C. Penyakit Umum Pada Balita.....	17
D. Pencegahan Penyakit Pada Balita.....	21
BAB 3 KONSEP MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT.....	25
A. Pengertian	25
B. Manfaat	27
C. Sasaran.....	28
D. Komponen Utama	28
E. Prinsip Utama	33
F. Tata Laksana Manajemen Terpadu Balita Sakit.....	35
G. Prosedur Penerapan Manajemen Terpadu Balita Sakit.....	41
BAB 4 INTEGRASI STRATEGI MTBS DENGAN PENDEKATAN HOLISTIK.....	43
A. Konseling Berbasis Keluarga.....	43
B. Promosi Kesehatan dan Peran Petugas Kesehatan....	49
C. Pemberdayaan Keluarga	54
D. Kolaborasi Multisektor.....	60

BAB 5 PENUTUP.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	73
GLOSARIUM	81
PROFIL PENULIS	85

BAB 1

PENDAHULUAN

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF menciptakan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), pendekatan holistik untuk mengelola penyakit utama pada anak-anak di bawah lima tahun. Tujuannya adalah menurunkan angka kematian, kesakitan, dan kecacatan yang disebabkan oleh penyakit yang dapat dicegah dan diobati serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara keseluruhan (Caron & Markusen, 2016).

Setiap tahun, lebih dari sepuluh juta anak di seluruh dunia meninggal sebelum mencapai usia lima tahun. Sebagian besar kematian ini disebabkan oleh lima kondisi yang sebenarnya dapat dicegah dan diobati, seperti pneumonia, diare, malaria, campak, dan malnutrisi, yang sering kali muncul sebagai kombinasi dari beberapa penyakit lain. Pada tahun 2005, WHO mengakui bahwa pendekatan MTBS sangat efektif diterapkan di negara-negara berkembang untuk mengurangi angka kematian, kesakitan, dan kecacatan pada bayi dan balita, asalkan diterapkan secara menyeluruh dan tepat. Pendekatan MTBS dianggap lengkap karena mencakup upaya preventif (pencegahan penyakit), perbaikan gizi, upaya promotif (konseling), dan upaya kuratif (pengobatan) (Robert E Black, Saul S Morris, 2003)

Untuk menangani masalah kesehatan utama pada anak-anak balita, Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), juga dikenal sebagai Integrated Management of Childhood Illness (IMCI), adalah pendekatan global yang dimaksudkan untuk

menggunakan strategi yang holistik, efektif, dan berbasis bukti. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF membuat program ini untuk mengurangi angka kematian anak, meningkatkan kualitas hidup, dan menjamin tumbuh kembang anak yang optimal, terutama di negara-negara berkembang (Vhuromu et al., 2022).

MTBS bukan sekadar kerangka teknis; itu adalah bagian penting dari upaya global untuk mencapai target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan pengurangan angka kematian anak. MTBS dapat menjadi alat yang berguna untuk menciptakan dampak jangka panjang dalam peningkatan kesehatan anak-anak di seluruh dunia dengan perencanaan yang matang dan evaluasi berkelanjutan (Vhuromu et al., 2022).

Pendekatan MTBS tidak hanya bertujuan untuk mengobati penyakit, tetapi juga berfokus pada pencegahan melalui edukasi keluarga, pemberdayaan keluarga dalam MTBS, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan primer. Ini dicapai melalui penyediaan panduan klinis yang sederhana dan berbasis bukti kepada tenaga medis di fasilitas kesehatan primer untuk mendiagnosis dan mengelola penyakit secara efektif. MTBS telah diterapkan sebagai bagian dari upaya sistematis untuk meningkatkan derajat kesehatan balita di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia. Meskipun demikian, program ini masih menghadapi masalah, seperti logistik, kekurangan sumber daya manusia, dan kurangnya pengetahuan masyarakat. (Sudirman & Ali, 2019).

MTBS telah diterapkan sebagai bagian dari upaya sistematis untuk meningkatkan derajat kesehatan balita di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia. Meskipun demikian, program ini masih menghadapi masalah, seperti logistik,

kekurangan sumber daya manusia, dan kurangnya pengetahuan masyarakat. MTBS bukan sekadar kerangka teknis; itu adalah bagian penting dari upaya global untuk mencapai target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan pengurangan angka kematian anak. MTBS dapat menjadi alat yang berguna untuk menciptakan dampak jangka panjang dalam peningkatan kesehatan anak-anak di seluruh dunia dengan perencanaan yang matang dan evaluasi berkelanjutan (Vhuromu et al., 2022)

Pelatihan ini bertujuan untuk membekali tenaga kesehatan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menemukan, menangani, dan mencegah penyakit utama balita seperti pneumonia, diare, malaria, campak, dan masalah nutrisi lainnya. Pelatihan pra-layanan sangat penting untuk mendukung keberhasilan MTBS. Ada Tiga komponen utama terdiri dari MTBS Perbaikan Keterampilan Petugas Kesehatan: Petugas kesehatan dilatih untuk menilai kondisi balita secara menyeluruh dan memberikan pengobatan berbasis protokol melalui pelatihan berstandar global. Penguatan Sistem Kesehatan: Pelaksanaan program ini membutuhkan dukungan logistik, ketersediaan obat-obatan esensial, dan sistem informasi kesehatan yang memadai.

Perbaikan Peran Keluarga dan Komunitas: Edukasi keluarga tentang pentingnya perawatan kesehatan di rumah, imunisasi, gizi yang baik, dan tanda-tanda bahaya yang memerlukan perawatan medis (Kementerian Kesehatan RI, 2015).

Dengan tujuan meningkatkan kesehatan balita, Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) adalah pendekatan yang menggabungkan elemen preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif. Fokus utamanya adalah mengurangi kematian dan kesakitan balita, terutama karena penyakit yang dapat

dicegah seperti pneumonia, diare, malaria, campak, dan kekurangan gizi. Dalam upaya promotif dan preventif, MTBS sangat penting untuk mendidik masyarakat dan memberdayakan keluarga untuk mengetahui tanda-tanda bahaya, meningkatkan praktik perawatan kesehatan di rumah, dan mendorong imunisasi dan nutrisi yang baik (Gera et al., 2016).

Manajemen Terpadu Balita Sakit akan semakin lengkap penanganannya selain dari segi kuratif, juga dilakukan dengan pendekatan promotif dan preventif, akan tetapi hal ini seringkali menghadapi banyak tantangan diantaranya seperti kurangnya edukasi dan kesaran dari masyarakat. Di banyak wilayah, terutama di daerah terpencil, masyarakat masih kurang dididik tentang pentingnya langkah pencegahan seperti imunisasi, pemberian ASI eksklusif, dan sanitasi. Hal ini menyebabkan orang tua tidak dapat mengidentifikasi tanda-tanda bahaya pada balita mereka sehingga apabila anaknya sakit mereka tidak terlluau mempermasalahakan akan efek apabila tidak segera ditangani oleh petugas kesehatan terdekat (Ababa, 2019).

Strategi global yang dikenal sebagai manajemen terpadu balita sakit (MTBS) menitik beratkan supaya dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas balita akibat penyakit utama seperti pneumonia, diare, malaria, campak, dan malnutrisi. Strategi ini menekankan penggunaan pendekatan terpadu dalam pelayanan kesehatan anak, yang mencakup tindakan kuratif, preventif, dan promotif. Tiga komponen uta pengetahuan ibu balita, konseling ibu balita, dan dukungan dari profesional kesehatan sangat penting untuk keberhasilan implementasi MTBS. Ibu balita memainkan peran sentral dalam kesehatan anak, mengingat mereka adalah pengasuh utama yang mengawasi kebutuhan gizi, kebersihan, dan perawatan anak

sehari-hari. Namun, di berbagai daerah, pengetahuan ibu mengenai kesehatan balita masih terbatas (Joaquim Pinto et al., 2024)

Selain pengetahuan ibu, konseling sangat dibutuhkan oleh ibu balita untuk meningkatkan pengetahuan terkait tentang manajemen terpadu balita sakit, terkadang konseling kurang mendapatkan perhatian yang krusial sehingga banyak ibu balita yang tidak mengetahui manfaat dari manajemen terpadu balita sakit. Komponen konseling dalam MTBS dirancang untuk memberikan panduan praktis dan spesifik kepada ibu balita mengenai cara merawat anak selama dan setelah sakit. Konseling yang efektif mampu meningkatkan keterampilan ibu dalam merawat anak di rumah (Hanafiah, 2022).

Petugas kesehatan juga merupakan pilar utama dalam implementasi MTBS. Mereka tidak hanya memberikan layanan medis tetapi juga membangun hubungan kepercayaan dengan ibu balita. Petugas kesehatan terlatih mampu menggunakan protokol MTBS untuk mendiagnosis penyakit balita secara cepat dan memberikan pengobatan yang sesuai. Tenaga medis yang berpengalaman dalam penyuluhan promotif dan preventif seringkali tidak tersedia. Selain itu, fasilitas kesehatan primer di beberapa wilayah tidak memiliki logistik yang diperlukan untuk mendukung kegiatan preventif, seperti sumber daya untuk edukasi kesehatan atau kampanye imunisasi.

Strategi manajemen terpadu balita sakit sangat penting dalam menurunkan angka kematian anak, selain itu pendekatan ini bermanfaat untuk memperkuat keterkaitan antara ibu balita, petugas kesehatan, dan sistem pelayanan kesehatan. Pengetahuan ibu dan dukungan petugas

kesehatan, yang diperkuat melalui konseling yang efektif, menciptakan ekosistem kesehatan yang holistik. Dengan pendekatan ini, manajemen terpadu balita sakit tidak hanya bertujuan untuk menyembuhkan penyakit tetapi juga mendorong pemberdayaan keluarga dalam menjaga kesehatan anak secara mandiri (Bryce, Victora, et al., 2005).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bryce et al. (2005), penerapan MTBS dapat meningkatkan kelangsungan hidup anak di berbagai negara. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan MTBS dapat menurunkan angka kematian balita dengan meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan orang tua, dan peningkatan sistem kesehatan. Namun, untuk memastikan program MTBS berhasil meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan balita, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Ini disebabkan oleh kekurangan sumber daya manusia, infrastruktur kesehatan yang tidak memadai, dan kurangnya dukungan kebijakan (Bryce, Victora, et al., 2005).

Sreeramareddy et al. (2015) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa intervensi berbasis keluarga dan komunitas dalam kerangka MTBS sangat penting untuk menurunkan angka kematian bayi dan balita di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Edukasi orang tua dan pengasuh tentang cara mencari pengobatan, mengidentifikasi tanda-tanda bahaya, dan mengelola penyakit anak di rumah adalah bagian dari intervensi ini. Petugas kesehatan, keluarga, dan komunitas harus bekerja sama untuk menerapkan MTBS dengan baik. Sangat penting bagi ibu dan pengasuh anak untuk mendapatkan pendidikan dan konseling yang tepat

untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk merawat anak mereka. Dukungan petugas kesehatan juga penting dalam memberikan informasi yang akurat dan relevan serta membangun kepercayaan dengan komunitas. Namun, keterbatasan sumber daya, infrastruktur kesehatan yang tidak memadai, dan hambatan budaya adalah beberapa hambatan untuk menerapkan MTBS (Sreeramareddy et al., 2015).

Strategi manajemen terpadu balita sakit, implementasinya tidak akan berhasil apabila tidak adanya dukungan dari ibu balita, karena ibu balita merupakan bagian yang sangat penting dan berperan secara langsung terhadap kesehatan balita tersebut. pengetahuan ibu mengenai perawatan balita, baik dalam mengenali tanda bahaya, memilih perawatan medis yang tepat, maupun melakukan perawatan di rumah. Ibu yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang penyakit anak lebih mampu merespons penyakit secara cepat dan tepat, sehingga menurunkan risiko komplikasi. Penguatan pengetahuan ibu dapat dilakukan oleh petugas kesehatan memberikan informasi yang mudah dipahami oleh ibu mengenai langkah-langkah perawatan, seperti pentingnya hidrasi saat anak mengalami diare, pemberian antibiotik sesuai resep, dan menjaga nutrisi anak selama masa sakit. Selain itu harus ditingkatkannya dengan cara melakukan interaksi langsung melalui konseling membantu ibu merasa lebih percaya diri dalam mengelola kesehatan anak mereka. Hal ini sangat penting, terutama bagi ibu yang tinggal di wilayah dengan akses terbatas ke layanan kesehatan (Monsen, 2005)

Selain itu, peran serta masyarakat, terutama ibu dan keluarga, juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan MTBS. Edukasi kepada ibu mengenai tanda-tanda bahaya pada

balita, pentingnya imunisasi, serta praktik perawatan di rumah yang benar, dapat meningkatkan deteksi dini dan penanganan yang tepat terhadap penyakit pada balita. Dengan demikian, sinergi antara petugas kesehatan yang kompeten dan masyarakat yang teredukasi dengan baik diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian pada balita, serta meningkatkan derajat kesehatan anak secara keseluruhan (Rahmah & Astuti, 2021).

MTBS merupakan suatu pendekatan dalam pengelolaan balita yang sakit dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan anak. Penerapan pendekatan ini tidak hanya untuk menangani pneumonia, tetapi juga untuk mengelola penyakit lain yang menjadi penyebab utama kematian pada anak di bawah usia 5 tahun, seperti diare, malaria, pneumonia, campak, dan malnutrisi. Pengelolaan balita sakit ini dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar, seperti unit rawat jalan, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), dan pondok bersalin desa (polindes), dengan tujuan agar seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Pelaksanaan MTBS dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia (tenaga medis di puskesmas/pelaksana program), tatalaksana pelayanan, dan sarana pendukung. Hingga saat ini, pelaksanaan MTBS masih perlu dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan agar dapat memastikan pelayanan yang berkualitas dan mencakup seluruh sasaran (WHO, 2018).

BAB 2

KONSEP KESEHATAN BALITA

A. Pengertian Kesehatan Balita

Menurut WHO, kesehatan balita sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang ideal pada anak usia 0–5 tahun. Ini tidak hanya tidak memiliki penyakit atau kelemahan, tetapi juga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang mendukung (Monsen, 2005).

Kesehatan balita sebagai status kesehatan anak yang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor biologis (seperti nutrisi dan genetik), lingkungan fisik (seperti akses air bersih dan sanitasi), dan lingkungan sosial (seperti pendidikan ibu dan akses ke layanan kesehatan (Black et al., 2013).

Kesehatan balita sebagai keberhasilan dalam mengurangi angka kematian, kesakitan, dan kecacatan anak di bawah usia lima tahun melalui penerapan program kesehatan terpadu seperti Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Kesehatan balita termasuk mencegah penyakit, menjaga nutrisi, dan memberikan perawatan dasar (Bryce, Victora, et al., 2005)

Bhutta dan rekannya mendefinisikan kesehatan balita sebagai status yang dipengaruhi oleh intervensi berbasis bukti yang mencakup imunisasi, pemberian makanan tambahan, pengobatan penyakit infeksi, dan pendidikan keluarga. Mereka menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani masalah kesehatan balita di negara berkembang (Bhutta et al., 2013). Sedangkan

UNICEF mendefinisikan kesehatan balita sebagai kondisi kesejahteraan fisik dan mental anak yang memungkinkan mereka mencapai tonggak perkembangan secara optimal. Hal ini dicapai melalui akses terhadap layanan kesehatan dasar, imunisasi, gizi yang memadai, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak (Unicef, 2018)

Dari beberapa definisi mengenai kesehatan balita diatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kesehatan balita sangat luas dan mencakup semua aspek, termasuk fisik, mental, dan sosial, dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti biologis, lingkungan, dan sosial. Banyak ahli dan organisasi di seluruh dunia menekankan betapa pentingnya menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit sebagai strategi untuk mencegah penyakit pada balita dan bagaimana upaya keluarga dan masyarakat dapat membantu menjaga kesehatan balita.

B. Pendekatan Strategis Meningkatkan Kesehatan Balita

Kesehatan balita merupakan bagian yang krusial dalam pembangunan suatu negara. Adapun pendekatan-pendekatan strategis yaotu dengan menerapkan manajemen terapdu balita sakit bertujuan untuk meningkatkan kesehatan anak, khususnya balita, dalam konteks medis, keluarga, dan masyarakat serta menekankan pentingnya kolaborasi antarprofesional untuk memastikan tumbuh kembang optimal anak-anak. Adapun pendekatan-pendekatan strategis untuk meningkatkan kesehatan balita yaitu sebagai berikut:

1. Fokus pada Kesehatan Balita

Monsen memulai dengan membahas tantangan kesehatan utama yang sering dihadapi balita, seperti malnutrisi, infeksi saluran pernapasan, diare, dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Ia

menyoroti bahwa masalah-masalah ini sering kali diperburuk oleh ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.

2. Peran Perawat dalam Meningkatkan Kesehatan

Penghargaan khusus pada peran perawat anak (pediatric nurses). Perawat tidak hanya bertindak sebagai pemberi layanan kesehatan, tetapi juga sebagai edukator bagi orang tua, peneliti, dan advokat kebijakan kesehatan anak. Monsen menekankan bahwa pelatihan perawat dalam hal pengetahuan medis dan kemampuan komunikasi sangat penting untuk mengoptimalkan hasil kesehatan balita.

3. Kolaborasi Antarprofesional

Kolaborasi antar berbagai disiplin ilmu melibatkan dokter, perawat, ahli gizi, dan pekerja sosial dianggap sebagai pendekatan kunci dalam meningkatkan kesehatan balita. Monsen menunjukkan bahwa program-program yang terintegrasi dan berpusat pada keluarga memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan pendekatan yang terfragmentasi.

4. Keseimbangan antara Intervensi Klinis dan Edukasi Keluarga

Keseimbangan antara intervensi medis dan edukasi keluarga. Orang tua memegang peranan penting dalam memastikan kesehatan anak di rumah, baik melalui praktik kebersihan, pola makan yang sehat, maupun stimulasi perkembangan yang memadai.

5. Implikasi Kebijakan dan Praktik

Untuk mengintegrasikan MTBS ke dalam kebijakan kesehatan anak. Ia menekankan bahwa pendekatan berbasis bukti (evidence-based practice) harus menjadi dasar dalam merancang program kesehatan anak. medis,

tetapi merupakan upaya kolektif yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan pemerintah (Monsen, 2005).

Untuk meningkatkan kesehatan balita, pendekatan sistemik sangat diperlukan dengan melibatkan keluarga, tenaga pendidik, dan pemerintah diperlukan. Kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita dengan memprioritaskan kualitas layanan dan kerja sama lintas sektor, adapun startegi-strategi yang dapat dilakukan sebagai berikut: (Schulman & Analyst, 2011).

1. Pentingnya Kualitas dalam Perawatan Anak Usia Dini

Schulman dan Analyst menekankan bahwa kesehatan balita sangat dipengaruhi oleh lingkungan perawatan dan pendidikan di usia dini. Mereka menemukan bahwa program perawatan berkualitas tinggi dapat mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan fisik anak. Aspek seperti pelatihan tenaga pendidik, rasio anak-guru yang ideal, dan kurikulum berbasis perkembangan adalah kunci keberhasilan.

2. Program untuk Bayi dan Balita

Program pengasuhan berbasis komunitas yang menyediakan akses ke layanan kesehatan preventif dan nutrisi. Contohnya adalah program imunisasi, pemberian ASI eksklusif, dan edukasi tentang gizi seimbang bagi keluarga.

3. Kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat

Inisiatif ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah negara bagian, penyedia layanan anak usia dini, dan komunitas. Model kemitraan ini memungkinkan penyedia layanan kesehatan dan pendidikan untuk berbagi sumber daya dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi balita.

4. Fokus pada Pelatihan Tenaga Kerja

Menyoroti perlunya pelatihan bagi pengasuh dan pendidik di pusat perawatan anak. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang kebutuhan kesehatan anak, deteksi dini penyakit, serta stimulasi perkembangan kognitif dan emosional. Dengan pengasuh yang kompeten, balita dapat menerima dukungan optimal untuk pertumbuhannya.

5. Kesejahteraan Keluarga sebagai Fokus

Program-program ini juga menyoroti peran penting keluarga dalam kesehatan anak. Beberapa inisiatif menawarkan layanan konseling keluarga, pelatihan parenting, dan dukungan finansial untuk memastikan bahwa orang tua dapat menciptakan lingkungan rumah yang sehat.

6. Dampak pada Kebijakan Publik

Negara bagian harus menjadikan kesehatan dan kesejahteraan balita sebagai prioritas dalam kebijakan publik. Dengan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program perawatan anak usia dini, pemerintah dapat menciptakan dampak jangka panjang pada generasi mendatang (Schulman & Analyst, 2011).

Untuk meningkatkan kesehatan balita diperlukan juga meningkatkan dukungan dari pelaksanaan program-program kesehatan. Untuk meningkatkan keberhasilan program manajemen terpadu balita sakit tidak terlepas dari peran kader posyandu sebagai penggerak di tingkat komunitas. Dengan pendekatan berbasis masyarakat yang didukung pelatihan intensif, program ini mampu memberikan dampak signifikan pada kesehatan dan perkembangan balita. Adapun strategi yang perlu

diterapkan sebagai upaya dalam meningkatkan kesehatan balita antara lain : (Mitra et al., 2024).

1. Fokus Program Intervensi Dini

Program ini merupakan pendekatan terintegrasi yang dirancang untuk mendeteksi dan menangani keterlambatan tumbuh kembang pada balita. Program ini mencakup evaluasi aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial balita sejak usia dini. Deteksi dini dianggap penting untuk memberikan intervensi yang tepat waktu dan memaksimalkan potensi anak.

2. Peran Kader Posyandu

Kinerja kader posyandu sebagai ujung tombak pelaksanaan program di tingkat komunitas. Para kader dilatih untuk melakukan skrining perkembangan anak, memberikan edukasi kepada orang tua, dan merujuk kasus yang membutuhkan penanganan lebih lanjut ke fasilitas kesehatan.

Adapun tugas utama Kader:

- a. Melakukan pencatatan dan pemantauan berat badan serta tinggi badan balita.
- b. Menggunakan alat deteksi perkembangan seperti Developmental Pre-Screening Questionnaire (Kuesioner Pra-Skrining Perkembangan, KPSP).
- c. Memberikan edukasi tentang stimulasi perkembangan sesuai usia balita.

3. Metode dan Pelatihan

Keberhasilan program sangat bergantung pada pelatihan kader. Modul pelatihan mencakup pemahaman tentang indikator perkembangan anak, cara melakukan stimulasi yang sesuai, dan teknik komunikasi dengan keluarga. Dengan pengetahuan yang memadai, kader dapat meningkatkan kualitas layanan posyandu.

4. Tantangan dan Solusi

Beberapa tantangan yang dihadapi kader meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan dari keluarga, dan rendahnya kesadaran masyarakat, Penyediaan fasilitas pendukung seperti alat ukur perkembangan dan panduan edukasi. Pelatihan berkelanjutan bagi kader posyandu. Kampanye untuk meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya program manajemen terpadu balita sakit.

Keterlibatan kader secara aktif meningkatkan deteksi dini masalah tumbuh kembang anak. Selain itu, program ini berhasil meningkatkan pemahaman orang tua tentang pentingnya stimulasi perkembangan dan menciptakan lingkungan rumah yang mendukung kesehatan balita sehingga program manajemen terpadu balita sakit terintegrasi dengan baik dengan adanya langkah pencegahan dengan upaya deteksi dini tumbuh kembang balita (Mitra et al., 2024).

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor kesehatan utama bagi balita, kita perlu memahami berbagai aspek yang memengaruhi kesehatan dan perkembangan mereka di usia dini, seperti kesehatan fisik, nutrisi, imunisasi, perkembangan mental dan emosional, akses layanan kesehatan, sanitasi, dan lingkungan. Dengan pendekatan holistik terhadap kesehatan balita, kita dapat memahami elemen-elemen penting yang mempengaruhi masa depan mereka. Berdasarkan Widarsa (2016), berikut adalah faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesehatan balita: (J Pinto et al., 2024)

1. Komponen Fisik

Kesehatan fisik balita meliputi kesehatan umum, kondisi kesehatan spesifik, dan pencegahan cedera.

Kesehatan umum mencakup pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, termasuk pengukuran berat badan, tinggi badan, dan perkembangan organ tubuh. Kondisi kesehatan spesifik mengacu pada pengenalan dan penanganan penyakit seperti infeksi dan gangguan pernapasan. Pencegahan cedera bertujuan melindungi balita dari potensi bahaya di sekitar mereka, seperti menjaga keamanan di rumah dan mengawasi saat bermain.

2. Nutrisi

Gizi yang seimbang sangat penting untuk pertumbuhan balita. Pemberian ASI eksklusif adalah bagian penting dari nutrisi terbaik untuk balita, yang memberikan kekebalan dan nutrisi yang mendukung perkembangan fisik dan mental. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak membantu mendeteksi kemungkinan masalah gizi atau kekurangan nutrisi.

3. Imunisasi

Menjaga jadwal imunisasi yang tepat adalah kunci untuk melindungi balita dari penyakit menular berbahaya seperti campak, polio, dan hepatitis. Vaksin yang aman dan efektif membantu mencegah penyebaran penyakit ini dan melindungi kesehatan balita.

4. Perkembangan Emosional dan Mental

Stimulasi kognitif sangat penting untuk perkembangan otak balita. Permainan dan aktivitas yang merangsang perkembangan kognitif sangat berpengaruh. Selain itu, lingkungan yang aman dan penuh kasih juga mendukung perkembangan emosional yang sehat. Memantau tahap perkembangan kognitif

dan emosional balita membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan memberikan dukungan yang diperlukan.

5. Edukasi Orang Tua

Pendidikan orang tua mengenai pentingnya memiliki akses layanan kesehatan yang mudah dan cara pencegahan penyakit sangat penting untuk mendukung perkembangan optimal balita. Pengetahuan ini memungkinkan orang tua untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif.

6. Kebersihan dan Sanitasi

Akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang baik sangat penting untuk kesehatan balita. Kebersihan lingkungan yang terjaga, termasuk tempat tidur, perabotan, dan mainan, mencegah paparan kuman dan alergen. Menjaga kualitas air, sanitasi, dan kebersihan ruang publik seperti kamar mandi dan toilet penting untuk mencegah penyebaran penyakit infeksi yang dapat membahayakan kesehatan balita (J Pinto et al., 2024).

C. Penyakit Umum Pada Balita

Kementerian Kesehatan telah menetapkan 5 Sasaran Strategis dalam Rencana Pembangunan Kesehatan 2020–2024, yang kemudian dibagi menjadi 8 Sasaran Strategis. Meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat adalah salah satu dari delapan Sasaran Strategis tersebut. Tantangan utama dalam mencapai rencana pembangunan kesehatan adalah mengatasi kendala dalam mengakses layanan kesehatan. Kendala tersebut dapat berupa kendala ekonomi, geografis, epidemiologi, maupun budaya. Kendala tersebut dapat memengaruhi peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, termasuk keteraturan penimbangan balita (memastikan anak di bawah lima tahun ditimbang

minimal 8 kali dalam 12 bulan terakhir). Oleh karena itu, upaya kesehatan anak harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan. Upaya tersebut ditujukan kepada anak sejak dalam kandungan sampai dengan usia 18 tahun. Salah satu tujuan utama upaya kesehatan anak adalah menjamin kelangsungan hidup anak melalui penurunan angka kematian bayi baru lahir, bayi, dan balita (kementerian kesehatan., 2020).

Anak-anak di bawah lima tahun memiliki sistem kekebalan yang belum sepenuhnya berkembang, yang membuat mereka lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Berikut ini adalah penjelasan tentang beberapa penyakit yang sering dialami oleh balita antara lain: (Kemenkes RI, 2023)

1. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)

ISPA adalah infeksi yang menyerang saluran pernapasan, baik bagian atas (pilek, radang tenggorokan) maupun bawah (bronkitis, pneumonia). Penyakit ini dapat disebabkan oleh virus atau bakteri.

Gejala:

Batuk, pilek, demam, napas cepat, tarikan dinding dada, dan kesulitan bernapas.

Dampak:

Jika tidak diobati, ISPA berat seperti pneumonia dapat menyebabkan komplikasi serius atau kematian.

Pencegahan:

Imunisasi (contoh: vaksin Hib dan PCV), menjaga kebersihan, dan menjauhkan anak dari asap rokok.

2. Diare

Diare adalah buang air besar dengan tinja yang cair lebih dari tiga kali sehari. Penyebab utamanya adalah infeksi virus (rotavirus), bakteri, atau parasit.

Gejala:

Dehidrasi (mulut kering, kurang buang air kecil, mata cekung), demam, muntah, dan penurunan nafsu makan.

Dampak:

Diare berat dapat menyebabkan dehidrasi serius, yang berpotensi mengancam nyawa.

Pencegahan:

Pemberian ASI eksklusif, kebersihan makanan dan minuman, serta imunisasi rotavirus.

3. Malaria

Penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles.

Gejala:

Demam berulang, menggigil, berkeringat, nyeri otot, lemas, dan anemia.

Dampak:

Malaria berat dapat menyebabkan komplikasi seperti kejang, koma, dan bahkan kematian.

Pencegahan:

Menggunakan kelambu berinsektisida, menghindari gigitan nyamuk, dan pemberian obat profilaksis di daerah endemik.

4. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Penyakit virus yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti.

Gejala:

Demam tinggi, nyeri otot, bintik merah di kulit, muntah, hingga pendarahan.

Dampak:

Jika tidak ditangani, DBD dapat berkembang menjadi syok dengue yang berbahaya.

Pencegahan:

Menguras dan menutup tempat penampungan air, menggunakan obat antinyamuk, dan imunisasi dengue (di beberapa wilayah).

5. Malnutrisi (Kurang Gizi)

Masalah kekurangan gizi yang meliputi gizi buruk (wasting), berat badan kurang (underweight), dan stunting (pendek). Gejala:

Berat badan tidak sesuai dengan usia, lemas, kurang aktif, dan sering sakit.

Dampak:

Malnutrisi dapat menghambat perkembangan otak dan fisik balita, meningkatkan risiko penyakit.

Pencegahan:

Pola makan bergizi, pemberian ASI eksklusif hingga 6 bulan, dan suplemen gizi.

6. Infeksi Kulit

Infeksi kulit seperti impetigo, eksim, atau dermatitis sering terjadi pada balita karena kulit mereka masih sensitif.

Gejala:

Ruam, kemerahan, gatal, luka yang bernanah, atau kulit yang mengelupas.

Dampak:

Infeksi berat dapat menyebar ke jaringan lebih dalam atau menyebabkan komplikasi.

Pencegahan:

Menjaga kebersihan kulit, menghindari gigitan serangga, dan perawatan luka yang baik.

7. Cacingan

Infeksi yang disebabkan oleh cacing seperti cacing gelang, cacing tambang, dan cacing kremi.

Gejala:

Nafsu makan menurun, perut buncit, anemia, dan berat badan sulit naik.

Dampak:

Infeksi cacing berat dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang.

Pencegahan:

Cuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan makanan, dan pemberian obat cacing secara rutin.

8. Otitis Media (Infeksi Telinga Tengah)

Infeksi yang sering terjadi pada balita, terutama setelah ISPA.

Gejala:

Nyeri telinga, demam, cairan keluar dari telinga, dan gangguan pendengaran.

Dampak:

Jika tidak diobati, dapat menyebabkan gangguan pendengaran permanen.

Pencegahan:

Menjaga kebersihan, menghindari paparan asap rokok, dan pemberian imunisasi pneumokokus.

D. Pencegahan Penyakit Pada Balita

Dikembangkan oleh WHO dan UNICEF, Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) adalah strategi kesehatan global untuk menangani penyakit balita secara terpadu di fasilitas kesehatan primer. Metode ini tidak hanya berfokus

pada pengobatan penyakit; itu juga berfokus pada pencegahan penyakit, deteksi dini, dan mendorong kesehatan balita (WHO, 2018).

Komponen Pencegahan Penyakit dalam Pendekatan MTBS dapat dilakukan dengan upaya antara lain adalah: (Kalu et al., 2016).

1. Imunisasi Lengkap

MTBS menekankan pentingnya pemberian imunisasi sesuai jadwal untuk melindungi balita dari penyakit serius seperti campak, pneumonia, dan polio. Tindakan Pencegahan dapat dilakukan dengan memastikan setiap balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap dan melakukan pengecekan status imunisasi selama kunjungan ke fasilitas kesehatan.

2. Pemberian ASI Eksklusif dan Nutrisi Optimal

Nutrisi yang baik membantu meningkatkan kekebalan tubuh balita dan mencegah malnutrisi. Tindakan Pencegahan dapat dilakukan dengan cara melakukan edukasi ibu tentang pentingnya ASI eksklusif selama enam bulan pertama. Pemantauan pertumbuhan dan gizi balita melalui pengukuran berat dan tinggi badan.

3. Pencegahan Infeksi melalui Kebersihan

MTBS mengintegrasikan pesan edukasi tentang pentingnya kebersihan untuk mencegah penyakit seperti diare dan cacingan. Tindakan Pencegahan: Mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah buang air (Gera et al., 2016). Penggunaan air bersih untuk minum dan memasak. Pengelolaan sampah yang baik untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit.

4. Pengendalian Penyakit Menular

Pengendalian penyakit seperti malaria dan demam berdarah menjadi bagian penting dari pendekatan MTBS. Tindakan Pencegahan:

Penggunaan kelambu berinsektisida untuk mencegah gigitan nyamuk. Penyuluhan tentang pentingnya menjaga lingkungan bebas dari genangan air yang dapat menjadi tempat berkembang biak nyamuk.

5. Deteksi Dini dan Perawatan Cepat

MTBS mendorong deteksi dini gejala penyakit pada balita, seperti demam, diare, atau gangguan pernapasan.

Tindakan Pencegahan:

Edukasi kepada orang tua untuk mengenali tanda bahaya penyakit. Rujukan cepat ke fasilitas kesehatan jika ada tanda bahaya.

6. Suplementasi dan Fortifikasi

MTBS merekomendasikan suplementasi zat gizi penting untuk mencegah defisiensi mikronutrien.

Tindakan Pencegahan:

Suplementasi vitamin A untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Pemberian obat cacing rutin untuk mencegah cacingan.

7. Pemantauan Tumbuh Kembang

Pemantauan berkala tumbuh kembang balita membantu mencegah masalah kesehatan sejak dini.

Tindakan Pencegahan:

Pengecekan rutin berat dan tinggi badan di posyandu. Edukasi kepada ibu tentang pentingnya stimulasi dini untuk perkembangan anak.

Peran orang tua sangat penting dalam mencegah penyakit pada balita. Pengetahuan, tindakan, dan pola asuh yang baik dari orang tua dapat mengurangi, meningkatkan kesehatan anak, dan menurunkan beban penyakit pada komunitas. Edukasi Orang Tua dengan cara memberikan penyuluhan tentang faktor risiko penyakit dan cara pencegahannya, baik melalui posyandu, puskesmas, maupun media kesehatan. Penghapusan polusi udara, mengurangi atau menghilangkan sumber polusi seperti asap rokok dan penggunaan bahan bakar tidak ramah lingkungan. Peningkatan Nutrisi. Meningkatkan asupan makanan bergizi yang dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh balita. Peningkatan Keterlibatan Keluarga: Memastikan orang tua memahami pentingnya deteksi dini gejala penyakit dan segera mencari pengobata serta melakukan Kolaborasi dengan fasilitas kesehatan serta lintas sektordengan cara melibatkan puskesmas dan posyandu untuk menyediakan akses edukasi, imunisasi, dan layanan kesehatan (Sukarto et al., 2016).

BAB 3

KONSEP MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT

A. Pengertian

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF (1995) yang dimaksud dengan manajemen terpadu balita sakit berujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kematian, penyakit, dan kecacatan di kalangan anak-anak di bawah usia lima tahun, MTBS atau Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) menggabungkan pendekatan berbasis bukti untuk diagnosis dan perawatan penyakit anak-anak yang paling umum (Department of Child and Adolescent Health, 2008).

MTBS adalah kerangka kerja berbasis masyarakat dan fasilitas kesehatan yang bertujuan meningkatkan penanganan penyakit anak dengan fokus pada pengelolaan kasus secara terpadu, edukasi kepada keluarga, dan pencegahan berbasis komunitas (Bryce, Boschi-pinto, et al., 2005).

Dalam konteks Indonesia, MTBS didefinisikan sebagai suatu pendekatan manajemen kesehatan balita di tingkat pelayanan primer yang melibatkan penilaian terpadu terhadap anak sakit, klasifikasi kondisi berdasarkan tingkat keparahan, pengobatan yang tepat, dan penyuluhan kepada orang tua. Program ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian balita akibat penyakit yang dapat dicegah (Kementerian Kesehatan RI, 2015).

Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Integrated Management of Childhood Illness (IMCI), adalah pendekatan terintegrasi dalam pengelolaan balita sakit yang datang ke fasilitas kesehatan. Pendekatan ini mencakup penilaian terhadap berbagai klasifikasi penyakit, status gizi, status imunisasi, serta penanganan medis dan konseling yang diberikan.

Untuk mengurangi angka kematian, salah satu cara yang efektif adalah dengan merawat anak yang menderita penyakit seperti pneumonia, diare, campak, dan malaria melalui perawatan jalan, terutama di puskesmas yang menerapkan pendekatan MTBS.

Definisi lain dari MTBS adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai upaya dalam pengelolaan balita sakit yang datang ke fasilitas kesehatan dasar. Upaya ini mencakup tindakan kuratif untuk penyakit seperti pneumonia, diare, campak, malaria, dan malnutrisi, serta upaya promotif dan preventif, termasuk imunisasi, pemberian vitamin A, dan konseling tentang pemberian makan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menurunkan angka kematian bayi dan balita serta mengurangi morbiditas akibat penyakit tersebut (Kementerian Kesehatan RI, 2015).

MTBS bukanlah sebuah program kesehatan tersendiri, melainkan sebuah pendekatan untuk menangani balita sakit. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengakui bahwa pendekatan MTBS sangat efektif diterapkan di negara-negara berkembang untuk mengurangi angka kematian, kesakitan, dan kecacatan pada bayi dan balita (Department of Child and Adolescent Health, 2008)

Black et al. (2003) mengatakan bahwa MTBS adalah intervensi berbasis bukti yang bertujuan untuk mengatasi

berbagai masalah kesehatan anak, seperti pneumonia, diare, malaria, malnutrisi, dan campak, dengan menerapkan pendekatan terpadu yang melibatkan langkah preventif dan kuratif (Robert E Black, Saul S Morris, 2003).

B. Manfaat

Program Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) bertujuan untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar, seperti yang dilakukan di Puskesmas. MTBS telah diterapkan di lebih dari 100 negara dan terbukti efektif dalam:

1. Mengurangi angka kematian balita
2. Meningkatkan status gizi anak
3. Meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan
4. Meningkatkan kinerja tenaga kesehatan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan biaya yang lebih efisien

Selain itu, MTBS memiliki tiga komponen utama yang memberikan keuntungan, yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam menangani kasus balita sakit, di mana tenaga non-dokter yang sudah dilatih juga dapat melakukan pemeriksaan dan perawatan.
2. Meningkatkan sistem kesehatan dengan mengintegrasikan berbagai program kesehatan dalam satu sesi pemeriksaan MTBS.
3. Meningkatkan praktik perawatan di rumah oleh keluarga dan masyarakat serta memperkuat upaya pencarian pertolongan bagi balita yang sakit, yang pada akhirnya memperkuat pemberdayaan keluarga dalam MTBS dalam pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2015)

C. Sasaran

Program Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) menysasar balita berusia 0 hingga 5 tahun, yang dibagi menjadi dua kelompok usia utama:

1. Anak usia 1 hari hingga 2 bulan

Kelompok ini meliputi bayi yang baru lahir hingga usia dua bulan, yang lebih rentan terhadap infeksi dan masalah gizi, serta memerlukan perawatan medis intensif.

2. Anak usia 2 bulan hingga 5 tahun

Kelompok ini mencakup balita yang lebih besar, yang berisiko tinggi terhadap penyakit seperti pneumonia, diare, campak, malaria, dan masalah gizi.

Tujuan utama dari MTBS adalah untuk mengurangi angka kematian dan kesakitan pada balita akibat penyakit yang dapat dicegah, serta meningkatkan kesehatan balita melalui pendekatan terintegrasi yang mencakup pengobatan medis, imunisasi, pemberian gizi, dan pemberian edukasi kepada orang tua (Kementerian Kesehatan RI, 2015)

D. Komponen Utama

MTBS dirancang untuk bekerja sama. Penurunan angka kematian dan peningkatan kualitas hidup balita di Indonesia dapat dicapai melalui peningkatan dan Pendekatan yang saling terintegrasi, yaitu melalui komponen pengelolaan kasus di fasilitas kesehatan, peningkatan keterampilan tenaga kesehatan, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2015)

1. Pengelolaan Kasus di Fasilitas Kesehatan

Komponen ini berfokus pada bagaimana tenaga kesehatan menangani balita yang sakit secara sistematis. Penanganan dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

a. Penilaian (Assessment):

Pemeriksaan menyeluruh untuk mengidentifikasi tanda bahaya umum (seperti kejang, ketidakmampuan untuk makan/minum, dan kesadaran menurun) serta tanda spesifik untuk penyakit seperti ISPA, diare, malaria, campak, atau malnutrisi.

b. Klasifikasi (Classification):

Berdasarkan hasil penilaian, kondisi balita diklasifikasikan menjadi:

Berat: Memerlukan rujukan segera ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi.

Sedang: Dapat ditangani di fasilitas kesehatan primer dengan pengobatan yang sesuai.

Ringan: Perawatan dapat dilakukan di rumah dengan edukasi kepada orang tua.

c. Tindakan (Treatment):

Tindakan mencakup pemberian obat sesuai panduan, rujukan jika diperlukan, serta nasihat perawatan rumah, seperti hidrasi oral pada diare dan pemberian makanan bergizi.

2. Peningkatan Keterampilan Tenaga Kesehatan

Agar penerapan MTBS berjalan optimal, tenaga kesehatan perlu memiliki keterampilan yang memadai. Komponen ini mencakup:

- a. Pelatihan Standar MTBS:
Pelatihan intensif untuk meningkatkan kemampuan diagnosis, klasifikasi, dan pengobatan berdasarkan algoritma yang telah disusun.
- b. Penyediaan Alat dan Panduan: Tenaga kesehatan diberikan alat bantu seperti chart booklet, pedoman obat-obatan, dan materi pelatihan untuk memastikan keseragaman dalam pelaksanaan.
- c. Supervisi dan Evaluasi:
Monitoring rutin dilakukan untuk memastikan kualitas layanan dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan lanjutan.

3. Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat

Komponen ini menekankan pentingnya peran keluarga dan komunitas dalam menjaga kesehatan balita. Strategi yang diterapkan mencakup:

- a. Edukasi Kesehatan:
Orang tua diberi pemahaman tentang tanda bahaya penyakit, pentingnya imunisasi, dan perawatan gizi yang baik.
- b. Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS):
Mengajarkan masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan, mencuci tangan, dan air minum bersih untuk mencegah penyakit.
- c. Kemitraan dengan Tokoh Masyarakat:
Melibatkan kader kesehatan, pemimpin komunitas, dan tokoh agama untuk menyebarkan informasi tentang kesehatan anak (Kementerian Kesehatan RI, 2015).

Komponen utama Manajemen Terpadu Balita Sakit (Integrated Management of Childhood Illness/IMCI) antara lain: (Basaleem & Amin, 2011).

1. Penilaian Kasus (Assessment of Illness)

Identifikasi gejala utama: Fokus pada gejala yang sering menyebabkan kematian anak, seperti pneumonia, diare, malaria, dan malnutrisi.

Pemeriksaan fisik: Melibatkan observasi tanda-tanda bahaya umum, seperti kesulitan bernapas, dehidrasi, dan berat badan anak. Konsultasi dengan orang tua: Menggali informasi tambahan tentang gejala dan riwayat penyakit anak.

2. Klasifikasi Penyakit (Classification of Illness)

Penyakit dikelompokkan berdasarkan tingkat keparahan dan urgensinya. Warna kategori sering digunakan untuk memudahkan klasifikasi, misalnya:

Merah: Kasus darurat yang membutuhkan rujukan segera.

Kuning: Perawatan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Hijau: Perawatan dasar di rumah dengan edukasi orang tua.

3. Penatalaksanaan (Treatment)

Obat-obatan: Memberikan antibiotik, antimalaria, atau oralit sesuai kebutuhan.

Tindakan gizi: Memberikan saran tentang nutrisi, seperti pemberian ASI eksklusif atau suplementasi vitamin.

Rujukan: Untuk kasus berat, rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap adalah langkah yang diambil.

4. Pendidikan Orang Tua (Parental Education)

Pemahaman gejala bahaya: Memberikan informasi kepada orang tua tentang tanda-tanda penyakit serius yang memerlukan tindakan cepat.

Praktik perawatan di rumah: Mengajarkan cara memberikan oralit, menjaga kebersihan, dan memberikan nutrisi yang tepat.

Promosi kesehatan: Mendorong imunisasi lengkap dan pemeriksaan rutin.

5. Tindak Lanjut (Follow-Up)

Anak yang telah menjalani pengobatan dipantau untuk memastikan efektivitas terapi dan mendeteksi komplikasi.

Memberikan dorongan kepada orang tua untuk kembali ke fasilitas kesehatan jika gejala tidak membaik.

6. Sistem Pendukung (Support Systems)

Pelatihan tenaga kesehatan: Staf kesehatan perlu dilatih untuk mengadopsi pendekatan IMCI secara efektif.

Ketersediaan logistik: Obat-obatan dan peralatan medis yang dibutuhkan harus tersedia di semua fasilitas kesehatan.

Manajemen data: Dokumentasi yang akurat diperlukan untuk evaluasi dan peningkatan layanan kesehatan.

E. Prinsip Utama

Adapun prinsip utama, antara lain: (Black et al., 2017)

1. Pendekatan Terpadu (Integrated Approach)

1. MTBS mengintegrasikan berbagai aspek kesehatan balita untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit dengan cara yang komprehensif.
2. Penyakit tidak dilihat sebagai entitas tunggal, tetapi sebagai bagian dari kondisi kesehatan anak secara keseluruhan.

2. Berbasis Bukti (Evidence-Based Practice)

1. MTBS menggunakan pedoman yang telah dikembangkan berdasarkan bukti ilmiah terkini untuk menangani penyakit prioritas seperti pneumonia, diare, malaria, campak, dan malnutrisi.
2. Prinsip ini memastikan bahwa intervensi yang diberikan efektif, aman, dan sesuai dengan standar global.

3. Fokus pada Penyakit Umum Penyebab Kematian Anak

1. MTBS memberikan perhatian khusus pada penyakit yang paling sering menyebabkan kematian balita, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, malnutrisi, malaria, dan penyakit lainnya.
2. Penyakit ini sering kali dikelola secara bersamaan karena adanya tumpang tindih gejala.

4. Kemudahan Diagnostik (Simplified Diagnostic Tools)

1. MTBS menggunakan panduan visual seperti bagan warna (merah, kuning, hijau) untuk membantu tenaga kesehatan mengklasifikasikan penyakit sesuai tingkat keparahan.

2. Sistem ini memudahkan diagnosis bahkan bagi petugas kesehatan di tingkat layanan primer.

5. Efisiensi Layanan (Efficiency in Healthcare Delivery)

Pendekatan terpadu memungkinkan tenaga kesehatan menangani lebih dari satu masalah kesehatan dalam satu kunjungan, sehingga menghemat waktu dan biaya.

6. Pemberdayaan Orang Tua (Parental Empowerment)

1. Orang tua diberi pengetahuan tentang tanda-tanda bahaya, cara memberikan perawatan di rumah, dan pentingnya mengikuti jadwal imunisasi.
2. Ini membantu meningkatkan keterlibatan keluarga dalam menjaga kesehatan anak mereka.

7. Promosi Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Health Promotion and Disease Prevention)

1. MTBS menekankan pentingnya imunisasi, pemberian ASI eksklusif, pemantauan tumbuh kembang anak, dan peningkatan status gizi untuk mencegah penyakit.
2. Pencegahan dianggap lebih baik daripada pengobatan untuk menurunkan angka kematian balita.

8. Sistem Pelayanan Berjenjang (Hierarchical Health System)

Prinsip ini mengacu pada pengelolaan kasus berdasarkan tingkat keparahan:

- a. Kasus berat: Dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.
- b. Kasus ringan hingga sedang: Ditangani di Puskesmas atau Posyandu dengan intervensi sederhana.

9. Monitoring dan Tindak Lanjut (Monitoring and Follow-Up)

1. Anak yang telah dirawat dipantau secara berkala untuk memastikan kesembuhan total dan mencegah komplikasi.
2. Prinsip ini penting untuk memastikan efektivitas sistem layanan kesehatan.

10. Konteks Lokal (Local Adaptation)

- a. MTBS disesuaikan dengan kondisi epidemiologi, budaya, dan kapasitas layanan kesehatan lokal di Indonesia.
- b. Ini mencakup perhatian pada penyakit endemik dan tantangan geografis tertentu.

F. Tata Laksana Manajemen Terpadu Balita Sakit

Pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) melibatkan beberapa langkah dalam menangani penyakit seperti pneumonia, diare, malaria, campak, dan malnutrisi pada balita. Berikut adalah penjelasan mengenai langkah-langkah manajemen terpadu balita sakit:

1. Menilai dan mengklasifikasi kondisi anak yang sakit

Menilai anak, berarti melakukan evaluasi terhadap tanda dan gejala penyakit yang muncul pada anak usia 2 bulan hingga 5 tahun, melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik (Depkes RI, 2006). Proses ini dimulai dengan:

- a. Menanyakan usia anak.
- b. Menanyakan kepada ibu tentang masalah kesehatan yang dialami anak.
- c. Memeriksa tanda bahaya umum.

Tanda bahaya umum pada anak sakit meliputi ((Kementerian Kesehatan RI, 2015):

- a. Anak tidak bisa minum atau menetek Anak dikategorikan "tidak bisa minum atau menetek" jika ia terlalu lemah untuk minum atau tidak dapat menghisap atau menelan saat diberi minuman atau susu.
- b. Anak selalu memuntahkan segala sesuatu Anak yang tidak dapat menelan apapun akan memuntahkan semua yang masuk, baik makanan maupun cairan. Namun, jika anak masih dapat menelan sedikit cairan, tanda bahaya ini tidak terlihat.
- c. Anak mengalami kejang Pada saat kejang, tubuh anak, terutama lengan dan kaki, akan menjadi kaku akibat kontraksi otot.
- d. Anak tampak letargis atau tidak sadar Anak yang letargis atau tidak sadar sulit dibangunkan dan tampak mengantuk atau dengan pandangan kosong, tidak memperhatikan sekitarnya.

Langkah-langkah selanjutnya dalam penilaian meliputi:

- a. Menanyakan kepada ibu mengenai empat keluhan utama yang dialami anak, yaitu batuk dan kesulitan bernapas, diare, demam, serta masalah telinga.
- b. Memeriksa dan mengklasifikasi status gizi dan anemia anak.
- c. Memeriksa status imunisasi dan pemberian vitamin A, serta menentukan apakah anak memerlukan imunisasi atau vitamin pada kunjungan tersebut.
- d. Menilai masalah atau keluhan lain yang mungkin dihadapi anak ((Kementerian Kesehatan RI, 2015).

Setelah menilai tanda dan gejala yang muncul, langkah berikutnya adalah membuat klasifikasi. "Membuat Klasifikasi" berarti menentukan kemungkinan

penyakit atau masalah yang dialami anak serta tingkat keparahannya (Kementerian Kesehatan RI, 2015).

Klasifikasi dilakukan berdasarkan hasil penilaian tanda dan gejala, yang dikelompokkan sesuai tingkat kegawatannya. Klasifikasi ini mencakup pneumonia, dehidrasi, diare persisten, disentri, malaria, campak, DBD, masalah telinga, dan status gizi. Untuk anak dengan keluhan utama berupa batuk dan kesulitan bernapas, klasifikasi dilakukan untuk menentukan kemungkinan pneumonia atau infeksi saluran pernapasan berat lainnya. Penilaian terhadap anak dengan keluhan ini mencakup:

a. Durasi batuk atau kesulitan bernapas

Jika anak mengalami batuk atau kesulitan bernapas selama lebih dari 30 hari, kemungkinan besar anak tersebut menderita batuk kronis. Hal ini bisa menjadi tanda TBC, asma, batuk rejan, pneumonia, atau penyakit lainnya. Klasifikasi untuk batuk atau kesulitan bernapas dibagi menjadi tiga kategori:

Lajur merah muda: Anak memerlukan perhatian segera dan harus dirujuk karena kondisi dianggap berat.

Lajur kuning: Anak membutuhkan tindakan khusus seperti pemberian antibiotik, antimalaria, cairan dengan pengawasan, atau pengobatan lainnya.

Lajur hijau: Anak tidak memerlukan tindakan medis khusus, dan tenaga kesehatan dapat memberikan panduan kepada ibu untuk merawat anak di rumah.

b. Napas cepat

Napas cepat diketahui dengan menghitung frekuensi napas anak dalam satu menit. Batas napas cepat tergantung pada usia:

Usia 2 bulan hingga <1 tahun: ≥ 50 kali per menit.

Usia 1 hingga <5 tahun: ≥ 40 kali per menit.

c. Tarikan dinding dada ke dalam

Tarikan dinding dada ke dalam terjadi jika dinding dada bagian bawah terlihat masuk ke dalam saat anak menarik napas. Pada kondisi pernapasan normal, dinding dada (bagian atas dan bawah) serta perut bergerak keluar. Tarikan ini dianggap ada jika terlihat jelas dan berlangsung terus-menerus. Namun, jika tarikan hanya terjadi saat anak menangis atau diberi makan, maka tidak dianggap sebagai tarikan dinding dada ke dalam.

d. Stridor pada anak yang tenang

Stridor adalah suara kasar yang terdengar saat anak menarik napas. Hal ini disebabkan oleh pembengkakan pada laring, trakea, atau epiglotis, yang menghalangi aliran udara ke paru-paru dan dapat membahayakan jiwa anak. Stridor berbeda dari wheezing; stridor terjadi saat menarik napas, sedangkan wheezing terjadi saat menghembuskan napas (Kementerian Kesehatan RI, 2015).

2. Menentukan Tindakan dan Memberikan Pengobatan

Menentukan tindakan dan memberikan pengobatan mengacu pada upaya yang dilakukan di fasilitas kesehatan sesuai dengan klasifikasi penyakit yang telah ditentukan (Kementerian Kesehatan RI, 2015).

3. Memberikan Konseling kepada Ibu

Konseling yang diberikan dalam manajemen terpadu balita sakit usia 2 bulan hingga kurang dari 5 tahun meliputi:

- a. **Konseling Pemberian Makan pada Anak**
Konseling tentang pemberian makan dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:
- b. **Mengevaluasi pola pemberian makan**, termasuk frekuensi menyusui, pemberian makanan tambahan, serta pola makan saat anak sakit. Jika berat badan anak kurang, perlu ditanyakan jumlah dan jenis makanan atau minuman yang diberikan.
- c. **Memberikan saran pemberian makan berdasarkan usia**:
 - 1) **Usia 0-6 bulan**: Berikan ASI sesuai keinginan bayi minimal 8 kali sehari tanpa tambahan makanan lain.
 - 2) **Usia 6 bulan**: Berikan ASI minimal 8 kali sehari, ditambah makanan pendamping 2 kali sehari sebanyak 2 sendok makan berupa bubur yang dicampur sumber protein seperti telur, ikan, atau tahu.
 - 3) **Usia 6-12 bulan**: Tambahkan pemberian bubur nasi 3 kali sehari, disesuaikan dengan usia (contoh: 6 sendok makan untuk usia 6 bulan). Berikan makanan selingan 2 kali sehari, seperti bubur kacang hijau atau biskuit.
 - 4) **Usia 12-24 bulan**: Tambahkan nasi lembek dengan sumber protein seperti telur, ayam, dan ikan sebanyak 3 kali sehari, serta makanan selingan 2 kali sehari.
 - 5) **Usia 2 tahun ke atas**: Anak dapat mengonsumsi makanan keluarga 3 kali sehari dengan menu bergizi, serta makanan selingan 2 kali sehari.

- 6) Jika bayi usia di bawah 4 bulan diberi makanan tambahan, dorong ibu untuk meningkatkan produksi ASI dengan menyusui lebih sering.
- 7) Anjurkan ibu mengganti botol susu dengan cangkir untuk kebersihan.
- 8) Jika anak susah makan, beri saran agar ibu membujuk anak serta mengamati jenis makanan yang disukai.
- 9) Selama sakit, jika pemberian makanan kurang optimal, dorong pemberian ASI lebih sering, makanan bervariasi, dan porsi kecil tetapi sering.

4. Konseling Pemberian Cairan Selama Sakit

Selama anak sakit, ibu perlu memastikan kebutuhan cairan terpenuhi dengan memberikan ASI lebih sering dan cairan tambahan seperti kuah sayur, air tajin, atau air putih.

5. Konseling Kunjungan Ulang

Berikan informasi kepada ibu mengenai pentingnya kunjungan ulang jika ditemukan tanda-tanda seperti:

- a. Kondisi anak memerlukan tindakan segera sesuai klasifikasi penyakit.
- b. Memberikan Pelayanan Tindak Lanjut pada Kunjungan Ulang

Pelayanan tindak lanjut dilakukan dengan mengevaluasi kondisi anak setelah pemberian pengobatan sebelumnya. Petugas akan menentukan langkah selanjutnya, misalnya: Jika ditemukan tanda bahaya atau tarikan dinding dada, beri antibiotik pilihan kedua atau suntikan kloramfenikol, lalu rujuk segera. Jika tidak ada perbaikan frekuensi napas atau nafsu makan, gantilah antibiotik atau lakukan rujukan. Jika ada perbaikan, lanjutkan pengobatan hingga

selesai (5 hari) dan tekankan pentingnya menghabiskan obat meskipun anak tampak membaik. Pelayanan tindak lanjut dilakukan pada kondisi seperti pneumonia, diare persisten, disentri, malaria, campak, demam berdarah, masalah telinga, dan gangguan gizi (Kementerian Kesehatan RI, 2015)

G. Prosedur Penerapan Manajemen Terpadu Balita Sakit

Prosedur Penerapan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) mencakup tiga langkah utama: persiapan, pelaksanaan, serta pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan.

1. Persiapan Penerapan MTBS

a. Diseminasi Informasi

Diseminasi informasi terkait MTBS kepada seluruh petugas puskesmas dilakukan melalui pertemuan yang melibatkan tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, petugas gizi, petugas imunisasi, petugas farmasi, pengelola SP2TP, pengelola P2M, petugas loket, dan lainnya.

b. Penyiapan Logistik

Sebelum penerapan MTBS, perlu dipastikan ketersediaan logistik seperti obat-obatan, alat kesehatan, formulir MTBS, dan Kartu Nasihat Ibu (KNI). Obat-obatan yang digunakan dalam MTBS umumnya sudah tercantum dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan dicatat dalam Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO).

2. Penerapan MTBS di Puskesmas

a. Pelaksanaan MTBS di puskesmas dapat dimulai dengan memperkirakan kemampuan fasilitas untuk menangani balita sakit secara bertahap hingga

cakupan layanan mencapai 100%. Besarnya cakupan layanan MTBS pada tahap awal dapat disesuaikan dengan kondisi puskesmas. Berikut panduan pelaksanaannya:

Jika jumlah kunjungan balita sakit kurang dari 10 orang per hari, semua balita sakit dapat langsung mendapatkan layanan MTBS.

- b. Jika kunjungan balita sakit berkisar 10–25 orang per hari, layanan MTBS dapat diberikan kepada 50% balita sakit pada tahap awal, dengan target seluruh balita menerima layanan dalam waktu 3 bulan.
- c. Jika kunjungan balita sakit mencapai 21–50 orang per hari, layanan MTBS dapat diberikan kepada 25% balita sakit pada tahap awal, dengan target seluruh balita menerima layanan dalam waktu 6 bulan.

3. Pencatatan dan Pelaporan Hasil Pelayanan

Pencatatan dan pelaporan layanan MTBS di puskesmas mengikuti Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP). Tidak diperlukan perubahan sistem pencatatan, namun klasifikasi MTBS perlu dikonversi ke dalam kode diagnosis yang sesuai sebelum dimasukkan ke sistem pelaporan SP2TP (Kementerian Kesehatan RI, 2015)

BAB 4

INTEGRASI STRATEGI MTBS DENGAN PENDEKATAN HOLISTIK

A. Konseling Berbasis Keluarga

Konseling berbasis keluarga adalah elemen penting dalam pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan keluarga, terutama ibu, agar lebih memahami, mencegah, dan mengatasi berbagai permasalahan kesehatan balita secara komprehensif. Fokus utamanya tidak hanya pada pengobatan penyakit, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup anak melalui keterlibatan aktif keluarga dalam proses perawatan (Kementerian Kesehatan RI, 2015)

Prinsip-Prinsip Konseling Berbasis Keluarga adalah:

1. Keluarga sebagai Mitra Utama

Konseling didesain untuk melibatkan ibu atau pengasuh utama balita sebagai tokoh kunci dalam proses perawatan anak. Hal ini menegaskan pentingnya peran mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar anak.

2. Edukasi yang Berbasis Kebutuhan Keluarga

Informasi yang diberikan dalam konseling disesuaikan dengan tingkat pemahaman, budaya, dan kondisi sosial-ekonomi keluarga agar lebih mudah dipahami dan diterapkan.

3. Berfokus pada Solusi Praktis

Konseling memberikan panduan langkah-langkah sederhana dan aplikatif, seperti cara pemberian makan

yang benar, menjaga kebersihan, serta perawatan balita saat sakit.

Komponen Utama Konseling Berbasis Keluarga dalam MTBS adalah:

1. Panduan Pemberian Makan dan Nutrisi Seimbang

Memberikan edukasi mengenai pola pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan, makanan pendamping ASI (MPASI) yang bergizi setelah usia 6 bulan, serta pola makan sehat bagi anak usia lebih dari 2 tahun.

2. Memantau status gizi balita dan memberikan saran untuk menangani anak dengan gizi kurang.

3. Perawatan Selama Sakit

Menyampaikan tanda bahaya pada balita, seperti demam tinggi, diare, atau sesak napas, dan pentingnya mencari bantuan medis segera.

4. Memberikan panduan perawatan di rumah, termasuk cara pemberian obat, pemenuhan cairan tubuh, dan pola makan yang sesuai selama anak sakit.

5. Kesehatan Lingkungan dan Kebersihan

Mengedukasi tentang praktik kebersihan, seperti mencuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan peralatan makan, dan memastikan air yang digunakan aman untuk dikonsumsi.

6. Perhatian pada Tumbuh Kembang Anak

Menekankan pentingnya stimulasi dini, pola tidur yang baik, serta deteksi dini jika terjadi keterlambatan perkembangan pada anak (Perry & Hodgins, 2021).

Tantangan dalam Pelaksanaan Konseling Berbasis Keluarga, diantaranya adalah:

1. Rendahnya Literasi Kesehatan

Beberapa keluarga, khususnya ibu, mungkin kesulitan memahami informasi kesehatan. Oleh karena

itu, penting untuk menggunakan bahasa yang sederhana serta alat bantu visual untuk meningkatkan pemahaman.

2. Keterbatasan Sumber Daya

Kondisi sosial-ekonomi sering membatasi akses keluarga terhadap gizi yang memadai atau layanan kesehatan. Solusi berbasis komunitas, seperti memanfaatkan posyandu, dapat menjadi alternatif.

3. Pengaruh Budaya dan Kebiasaan Lokal

Praktik budaya tertentu bisa menjadi hambatan dalam penerimaan pesan kesehatan. Pendekatan yang menghormati budaya lokal dapat meningkatkan keberhasilan konseling.

Dengan pendekatan berbasis keluarga, MTBS dapat lebih efektif dalam mendukung keluarga untuk menjaga kesehatan balita, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kesejahteraan anak secara holistik (Perry & Hodgins, 2021)

Pendekatan holistik dalam konseling keluarga bertujuan untuk mendukung kesehatan dan perkembangan balita secara menyeluruh, mencakup dimensi fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Penelitian Pitchik et al. (2021) menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas yang terintegrasi dapat membantu keluarga dalam mendukung perkembangan awal anak dengan optimal, seperti yang berhasil diterapkan di wilayah pedesaan Bangladesh.

Pendekatan Holistik dalam Konseling Keluarga

Pendekatan ini menempatkan anak dalam konteks lingkungan keluarga dan komunitasnya. Keluarga diberdayakan untuk memahami serta memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh. Beberapa prinsip yang dijelaskan oleh (Pitchik et al., 2021) meliputi:

1. Intervensi Multidimensional

Konseling keluarga mencakup edukasi terkait berbagai aspek kesehatan, seperti nutrisi, stimulasi kognitif, interaksi sosial, dan kebersihan lingkungan.

2. Pemberdayaan Ibu Melalui Kelompok Dukungan

Kelompok komunitas berfungsi untuk memberikan pelatihan praktis kepada ibu tentang pola makan sehat, pengasuhan yang positif, dan stimulasi perkembangan anak. Kelompok ini juga menjadi wadah berbagi pengalaman di antara para ibu.

3. Integrasi Edukasi dan Praktik

Edukasi dilakukan melalui sesi kelompok yang melibatkan praktik langsung, seperti membuat makanan bergizi dari bahan lokal, menjaga kebersihan, serta cara bermain untuk merangsang perkembangan anak.

4. Keterlibatan Keluarga Secara Luas

Tidak hanya ibu, ayah dan anggota keluarga lain juga dilibatkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

Komponen Konseling Berbasis Holistik

1. Nutrisi dan Pemberian Makan

Edukasi tentang ASI eksklusif, makanan pendamping ASI yang bergizi, dan cara mengatasi gizi buruk. Pelatihan pemanfaatan sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi anak.

2. Kesehatan dan Kebersihan Lingkungan

Promosi kebersihan pribadi seperti mencuci tangan dengan sabun dan sanitasi air minum.

3. Edukasi tentang manajemen lingkungan rumah untuk mengurangi risiko penyakit seperti diare dan infeksi pernapasan.

4. Stimulasi Perkembangan Anak

Edukasi cara memberikan stimulasi dini melalui permainan dan interaksi verbal.

Penekanan pada perkembangan sosial-emosional anak, termasuk membangun rasa percaya diri dan keterampilan sosial.

5. Pola Asuh Positif

Pelatihan komunikasi yang mendukung, memberikan penguatan positif, dan membangun hubungan emosional yang kuat antara orang tua dan anak (Pitchik et al., 2021)

Keberhasilan Pendekatan Holistik

Menurut Pitchik et al. (2021), pendekatan holistik berbasis keluarga mampu meningkatkan perkembangan kognitif, motorik, dan sosial-emosional anak secara signifikan. Keberhasilan ini dicapai melalui edukasi yang dirancang sesuai budaya dan kondisi lokal.

Keterlibatan aktif ibu dan komunitas, yang memperkuat adopsi praktik kesehatan yang baik.

Implikasi dalam Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

Integrasi pendekatan holistik dalam konseling keluarga mendukung implementasi MTBS secara lebih efektif dengan memperhatikan berbagai aspek kesehatan anak. Pendekatan ini:

1. Memberikan solusi menyeluruh untuk mengatasi masalah kesehatan.
2. Memastikan keluarga, khususnya ibu, memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
3. Membangun dukungan komunitas untuk keberlanjutan intervensi kesehatan (Pitchik et al., 2021).

Dalam manajemen terpadu balita sakit, sangat diperlukan pendekatan edukatif dan interaktif dalam konseling misalnya konseling nutrisi dapat meningkatkan pemahaman keluarga tentang kebutuhan gizi balita, yang pada akhirnya berkontribusi pada tumbuh kembang optimal anak. Konseling nutrisi adalah intervensi yang penting dan strategis untuk mendukung pertumbuhan balita. Dengan pendekatan edukatif yang disesuaikan dengan kebutuhan keluarga, konseling dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak secara keseluruhan (Natalianingsih, 2018).

Adapun tantangan yang sering dihadapi keluarga, seperti:

1. Kurangnya pengetahuan tentang kebutuhan gizi yang sesuai dengan usia balita.
2. Kebiasaan makan yang kurang sehat, termasuk konsumsi makanan instan atau bergizi rendah.
3. Faktor ekonomi dan budaya yang memengaruhi pola makan keluarga.

Konseling sebagai Solusi Konseling nutrisi dipaparkan sebagai metode yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut. Pendekatan ini melibatkan pemberian informasi dan panduan praktis kepada orang tua atau pengasuh tentang:

1. Pola makan sehat dan kebutuhan kalori harian.
2. Pentingnya nutrisi mikro seperti zat besi, vitamin A, dan kalsium dalam perkembangan balita.

Strategi Konseling

1. Edukasi Orang Tua

Konseling difokuskan pada pemberdayaan orang tua untuk memahami dan memenuhi kebutuhan gizi balita. Hal ini mencakup: menyusun rencana makan

harian yang seimbang, Memahami tanda-tanda kekurangan atau kelebihan gizi pada anak.

2. **Pendekatan Personal dan Interaktif**

Pendekatan personal dalam konseling, di mana petugas kesehatan: Menyesuaikan panduan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi keluarga. Melibatkan orang tua dalam diskusi dan pengambilan keputusan terkait nutrisi anak.

3. **Pemantauan dan Evaluasi**

Konseling dilengkapi dengan pemantauan rutin terhadap pertumbuhan balita, seperti pengukuran berat badan, tinggi badan, dan status gizi. Evaluasi ini membantu memastikan bahwa perubahan pola makan memberikan dampak positif terhadap perkembangan anak (Natalianingsih, 2018).

Konseling dalam manajemen terpadu balita sakit dilakukan dengan pendekatan keluarga dengan berfokus pada meningkatkan pengetahuan ibu balita dan keluarga dengan pemahaman terhadap upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menanganin balita sakit serta pemahaman dalam meningkatkan pencegahan penyakit dengan pendekatan keluarga.

B. Promosi Kesehatan dan Peran Petugas Kesehatan

Promosi kesehatan sebagai pendekatan sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan komunitas melalui metode holistik yang menitikberatkan pada pemberdayaan, lingkungan yang mendukung, serta kebijakan kesehatan yang baik. Konsep ini sangat relevan jika diterapkan dalam **Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)** (Nutbeam & Muscat, 2021).

Promosi kesehatan dalam MTBS bertujuan memperkuat kemampuan individu, keluarga, dan komunitas

dalam mencegah, mengenali, serta menangani penyakit balita melalui edukasi, pemberdayaan, dan penguatan sistem kesehatan. Artikel ini juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak serta penyesuaian program dengan budaya dan konteks lokal agar strategi tersebut berhasil (Nutbeam & Muscat, 2021).

Dalam menyukseskan Manajemen terpadu balita sakit membutuhkan integrasi antara pendekatan promotif dan preventif. Promosi kesehatan yang efektif tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat tetapi juga menciptakan perubahan perilaku yang mendukung kesehatan. Fungsi preventif memastikan langkah-langkah awal dilakukan untuk mencegah komplikasi dan penularan lebih lanjut. Dengan menekankan kolaborasi antara masyarakat, layanan kesehatan, dan sektor terkait lainnya, artikel ini memberikan kerangka kerja yang relevan untuk mengatasi tantangan kesehatan anak di tingkat lokal maupun global (Azriful et al., 2021)

1. Pendekatan Promotif

Intervensi sangat diperlukan dalam upaya promosi kesehatan dalam manajemen terpadu balita sakit, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mencegah ISPA. Beberapa langkah yang digambarkan dalam artikel meliputi: Edukasi kepada ibu dan keluarga tentang cara menjaga kebersihan rumah tangga, seperti ventilasi yang baik dan kebersihan lingkungan. Promosi praktik kesehatan, seperti mencuci tangan dengan sabun, penggunaan masker, dan etika batuk.

Peningkatan literasi kesehatan terkait faktor risiko ISPA, seperti paparan asap rokok atau polusi udara dalam ruangan.

2. Pendekatan Preventif

Fungsi preventif yang dijelaskan mencakup upaya untuk memutus rantai penularan ISPA dan mengurangi risiko komplikasi pada balita. Contohnya Program imunisasi rutin, terutama untuk penyakit seperti pneumonia dan influenza. Pemantauan status gizi balita untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Pemeriksaan kesehatan rutin di fasilitas kesehatan primer untuk deteksi dini dan penanganan cepat gejala ISPA (Azriful et al., 2021).

Peran petugas Kesehatan menggarisbawahi pentingnya dalam promosi dan pencegahan penyakit melalui:

1. Pelatihan tenaga kesehatan

untuk memberikan penyuluhan yang efektif kepada masyarakat. Penyediaan fasilitas kesehatan yang mendukung pengelolaan ISPA, seperti ruang perawatan dengan ventilasi baik.

2. Kolaborasi lintas sektor

termasuk dengan organisasi komunitas, untuk memperluas cakupan program promotif dan preventif.

3. Pendekatan Berbasis Komunitas

Misalnya: Pelibatan kader kesehatan dalam mendistribusikan informasi dan memantau kondisi kesehatan balita.

4. Pelaksanaan kampanye kesehatan melalui media lokal dan kegiatan komunitas (Basaleem & Amin, 2011).

Dalam manajemen terpadu balita sakit sangat pentingnya promosi kesehatan pada anak usia dini serta dampaknya terhadap kesehatan jangka panjang. Dalam melakukan upaya promkes, peran multidisiplin petugas kesehatan, keluarga, dan komunitas dalam membangun

dasar kesehatan yang kokoh sejak awal kehidupan. promosi kesehatan anak usia dini sebagai investasi berharga untuk masa depan kesehatan masyarakat. Dengan pendekatan berbasis bukti, kolaboratif, dan berfokus pada keluarga, petugas kesehatan berperan sentral dalam memastikan anak-anak mendapatkan awal kehidupan yang sehat. Strategi ini, ketika diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik kesehatan, dapat memberikan dampak positif sepanjang hayat (Ma et al., 2015).

Promosi kesehatan selama masa anak usia dini sangat penting karena:

1. Masa anak usia dini merupakan periode kritis untuk perkembangan fisik, mental, dan emosional.
2. Intervensi dini mampu mencegah berbagai masalah kesehatan kronis di masa depan, seperti obesitas, penyakit jantung, atau gangguan psikologis (Ma et al., 2015).

Strategi Promosi Kesehatan dan Manajemen Terpadu Balita Sakit

Dalam menyukseskan promosi kesehatan dalam manajemen terpadu balita sakit, diperlukan strategi komprehensif yang harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dengan pendekatan keluarga. Hal tersebut perlu melibatkan pembuat kebijakan, dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan. Dengan menggabungkan pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis kebijakan, buku ini menjadi panduan penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara holistik dan berkelanjutan (J Pinto et al., 2024).

Adapun strategi tersebut antara lain: (J Pinto et al., 2024)

1. Pendekatan Partisipatif

Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan, sehingga mereka merasa memiliki dan berkontribusi terhadap keberhasilan program.

2. Penggunaan Media Lokal:

Memanfaatkan media tradisional atau digital yang akrab dengan masyarakat untuk menyampaikan pesan kesehatan secara efektif.

3. Penguatan Literasi Kesehatan

Peningkatan literasi kesehatan adalah inti dari promosi kesehatan. Hal ini mencakup:

- a. Memberikan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh berbagai kelompok masyarakat.
- b. Mengajarkan keterampilan praktis untuk mengenali tanda-tanda awal penyakit, memahami informasi medis, dan mengambil keputusan kesehatan yang bijaksana.

4. Pemberdayaan Individu dan Komunitas

- a. Meningkatkan Kapasitas: Memberdayakan individu dan kelompok untuk mengambil langkah aktif dalam menjaga kesehatan mereka, seperti melalui pelatihan kader kesehatan.
- b. Membangun Jaringan Sosial: Mendorong komunitas untuk saling mendukung dalam mengadopsi perilaku hidup sehat.
- c. Kebijakan Berbasis Kesehatan
advokasi kebijakan yang mendukung promosi kesehatan, seperti: Mendorong regulasi yang mendukung akses layanan kesehatan, mengembangkan kebijakan publik yang melindungi

masyarakat dari risiko kesehatan, seperti larangan merokok di tempat umum.

5. Pendekatan Multidisiplin

Promosi kesehatan memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan sosial. Strategi multidisiplin ini bertujuan untuk:

- a. Memastikan bahwa semua aspek sosial yang memengaruhi kesehatan, seperti sanitasi, nutrisi, dan akses ke layanan medis, mendapatkan perhatian yang memadai.
- b. Mendorong inovasi dalam intervensi kesehatan yang berbasis bukti dan relevan dengan konteks lokal. Contoh Program Kesehatan Ibu dan Anak: Memberikan pelatihan bagi bidan desa dan kader kesehatan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan balita.
- c. Kampanye Gaya Hidup Sehat: Menggunakan media sosial untuk mempromosikan aktivitas fisik, pola makan seimbang, dan cek kesehatan rutin.

Integrasi pendekatan Holistik dalam promosi kesehatan dalam manajemen terpadu balita sakit dengan melibatkan: Petugas kesehatan dianjurkan untuk mengadopsi pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya fokus pada pengobatan, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pemberdayaan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan anak.

C. Pemberdayaan Keluarga

Pemberdayaan keluarga dalam manajemen terpadu balita sakit merujuk pada upaya untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan dukungan kepada keluarga agar dapat berperan aktif dalam mengelola kesehatan balita yang sakit. Hal ini mencakup pemahaman mengenai tanda-

tanda penyakit, langkah-langkah pencegahan, perawatan di rumah, serta kapan harus mencari perawatan medis lebih lanjut. Dalam konteks manajemen Pemberdayaan keluarga dalam manajemen terpadu balita sakit berfokus pada upaya untuk meningkatkan kemandirian keluarga dalam merawat balita dan memastikan bahwa keluarga dapat membuat keputusan yang tepat terkait kesehatan anak mereka. Pemberdayaan keluarga tidak hanya berfokus pada penanganan fisik, tetapi juga aspek emosional dan sosial dari perawatan balita sakit. Keluarga diberdayakan untuk menjadi bagian integral dari proses perawatan dengan cara yang kolaboratif, sehingga dapat memberikan lingkungan yang mendukung bagi pemulihan balita (Siti Suciati, 2023)

Beberapa konsep kunci dalam pemberdayaan keluarga untuk manajemen terpadu balita sakit antara lain: (Jackson et al., 2006)

1. Edukasi tentang Gejala dan Penyakit

Memberikan keluarga pengetahuan yang memadai tentang tanda-tanda dan gejala penyakit pada balita, termasuk cara mengenali penyakit serius yang memerlukan intervensi medis segera.

2. Pencegahan dan Perawatan di Rumah

Memberikan keterampilan kepada keluarga untuk merawat balita dengan penyakit ringan di rumah, termasuk pemberian obat yang tepat, pemantauan kondisi, serta cara menjaga kenyamanan dan keselamatan balita.

3. Akses ke Layanan Kesehatan

Mengedukasi keluarga tentang cara mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang tepat dan kapan harus mencari pertolongan medis jika kondisi balita tidak membaik atau memburuk.

4. Peningkatan Keterampilan Komunikasi

Mengajarkan keluarga untuk berkomunikasi secara efektif dengan tenaga medis mengenai kondisi balita mereka, serta mengajukan pertanyaan yang tepat terkait pengobatan dan perawatan.

5. Dukungan Sosial dan Emosional

Membangun sistem dukungan sosial bagi keluarga, karena perawatan balita yang sakit dapat menjadi pengalaman emosional yang berat. Keluarga perlu diberikan ruang untuk berbagi perasaan dan menerima dukungan dari komunitas.

Pemberdayaan keluarga digambarkan sebagai elemen penting yang menjadi penghubung antara sistem perawatan yang berfokus pada keluarga (family-centered systems of care) dan perbaikan fungsi anak. Pemberdayaan keluarga adalah mekanisme perubahan yang sangat penting dalam meningkatkan fungsi anak. Dengan memberdayakan keluarga melalui sistem perawatan yang inklusif dan suportif, hasil yang lebih baik dapat dicapai dalam berbagai aspek kesejahteraan anak. Pemberdayaan keluarga didefinisikan sebagai proses di mana keluarga memperoleh kendali, keyakinan, dan kompetensi dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Konsep ini menekankan bahwa keluarga memiliki peran sentral dalam mengelola kesehatan fisik, emosional, dan sosial anak, serta berpartisipasi aktif dalam sistem perawatan yang dirancang untuk mendukung anak (Graves & Shelton, 2007).

Peran Sistem Perawatan Berpusat pada Keluarga

Sistem perawatan yang berpusat pada keluarga menciptakan lingkungan yang mendukung dengan memberikan keluarga akses ke sumber daya, informasi, dan

pelatihan. Sistem ini mengakui keluarga sebagai mitra utama dalam perawatan anak, menghormati pilihan mereka, dan memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan unik keluarga.

Pemberdayaan sebagai Mediator

Pemberdayaan keluarga memainkan peran mediasi yang signifikan. Ketika sistem perawatan melibatkan keluarga secara aktif, tingkat pemberdayaan meningkat, yang pada gilirannya berdampak positif pada fungsi anak, termasuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan pencapaian akademik. Peningkatan Pengetahuan dan kompetensi Keluarga yang diberdayakan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan anak dan bagaimana cara memenuhinya. Hal ini membantu mereka mengambil keputusan yang lebih efektif terkait perawatan anak. Peningkatan Keyakinan Diri Proses pemberdayaan membantu keluarga merasa lebih percaya diri dalam mengelola tantangan yang terkait dengan kesehatan anak mereka, termasuk memahami opsi perawatan dan berkomunikasi dengan tenaga kesehatan. Peningkatan Partisipasi dalam Perawatan Keluarga yang diberdayakan lebih cenderung terlibat dalam proses perawatan, seperti merancang rencana perawatan, menetapkan tujuan bersama, dan memantau kemajuan anak.

Hasil Positif pada Anak: Melalui pemberdayaan keluarga, anak-anak menunjukkan perubahan positif, termasuk peningkatan fungsi emosional, sosial, dan perilaku. Hal ini mencerminkan dampak langsung dari dukungan keluarga yang lebih efektif (Graves & Shelton, 2007).

Pemberdayaan keluarga dalam MTBS bertumpu pada keterlibatan aktif individu dan kelompok dalam

pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ini mencakup partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan dan program kesehatan.

Selain itu, pemberdayaan ini melibatkan peningkatan kapasitas individu dan kelompok melalui edukasi, pelatihan, dan pengetahuan. Tujuannya adalah membekali mereka dengan kemampuan untuk membuat keputusan yang sehat, mengelola sumber daya, dan mengatasi tantangan kesehatan. Lebih lanjut, pemberdayaan keluarga dalam MTBS diarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan, di mana masyarakat dibekali pemahaman mengenai dampak jangka panjang dari keputusan mereka. Pendekatan ini juga mencakup upaya untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumber daya, informasi, serta layanan kesehatan, dengan menitikberatkan pada hak asasi manusia dan keadilan sosial (J Pinto et al., 2024).

Hubungan Antara Kesehatan dan Pemberdayaan keluarga dalam MTBS

Pemberdayaan keluarga dalam MTBS dalam bidang kesehatan dimulai dengan memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk membuat pilihan yang sehat. Pengetahuan mengenai pola makan seimbang, kebersihan, dan imunisasi adalah langkah awal untuk meningkatkan kesehatan individu. Dengan pemberdayaan, masyarakat dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan, termasuk merencanakan program kesehatan lokal, menentukan prioritas layanan, dan mengevaluasi dampak program tersebut. Masyarakat yang diberdayakan memiliki kemampuan lebih baik dalam mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan, memahami hak mereka terhadap perawatan, serta bersikap proaktif dalam

mendapatkan layanan yang sesuai. Selain itu, masyarakat yang sadar kesehatan cenderung menerapkan gaya hidup sehat, seperti menjaga pola makan, vaksinasi, dan kebersihan, secara lebih efektif. Pemberdayaan ini juga memiliki dampak positif pada kesehatan mental dan emosional, dengan mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis (Dembo, n.d.).

Pemberdayaan keluarga dalam MTBS dapat dilakukan melalui pelibatan komunitas dalam proses perencanaan program kesehatan. Dengan melibatkan masyarakat, program menjadi lebih relevan dan diterima secara luas, sehingga meningkatkan peluang keberhasilannya. Pendidikan kesehatan dan pelatihan keterampilan adalah bagian integral dari pemberdayaan keluarga dalam MTBS. Ini membantu masyarakat memahami cara merawat diri sendiri dan keluarga mereka.

Kampanye kesadaran kesehatan di tingkat komunitas juga menjadi strategi penting, misalnya melalui program peningkatan gizi atau imunisasi, untuk mendorong perubahan perilaku yang positif.

Masyarakat yang diberdayakan dapat membentuk kelompok pendukung untuk meningkatkan kondisi kesehatan mereka, memengaruhi kebijakan, serta memberikan bantuan kepada individu yang membutuhkan (Yeh et al., 2016).

Tantangan dalam Pemberdayaan keluarga dalam MTBS

Ketidaksetaraan sosial akibat perbedaan ekonomi, budaya, dan pendidikan sering menjadi hambatan dalam upaya pemberdayaan keluarga dalam MTBS. Komunitas yang kurang berkembang biasanya menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Program pemberdayaan

sering kali gagal ketika komunitas tidak memiliki dukungan yang memadai untuk mengatasi tantangan ini. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan inklusif sangat diperlukan untuk memastikan pemberdayaan keluarga dalam MTBS dapat memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan (Yeh et al., 2016).

Pemberdayaan keluarga merupakan upaya meningkatkan kemampuan orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan sosial anak-anak mereka. Proses ini melibatkan pelatihan, penyediaan informasi, serta penguatan kemampuan mereka untuk membuat keputusan dalam konteks medis. Kontribusi Pemberdayaan terhadap Pengurangan Dampak Psikologis Pendekatan yang melibatkan keluarga secara aktif, seperti partisipasi dalam perawatan medis anak dan peningkatan komunikasi, terbukti mampu mengurangi tekanan psikologis seperti stres, kecemasan, dan rasa tidak pasti yang dirasakan oleh anak-anak. Pendekatan ini juga membantu anak-anak membangun rasa percaya diri dalam menghadapi kondisi penyakit mereka. Strategi Pemberdayaan yang Efektif merupakan sejumlah model intervensi efektif, termasuk pendidikan kesehatan yang berfokus pada keluarga, dukungan kelompok sebaya untuk keluarga, serta terapi keluarga. Intervensi ini telah terbukti memperkuat hubungan antaranggota keluarga dan mengurangi dampak psikologis pada anak-anak (Mardhiyah et al., 2022).

D. Kolaborasi Multisektor

Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) merupakan pendekatan komprehensif untuk menangani penyakit pada balita, terutama di negara berkembang. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pengobatan medis tetapi juga

mencakup aspek preventif, edukasi, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan. Kolaborasi multisektoral adalah elemen penting dalam keberhasilan implementasi MTBS, karena melibatkan berbagai pihak yang berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya (Bryce, Victora, et al., 2005).

1. Sektor kesehatan

Menjadi tulang punggung MTBS, dengan tenaga medis di tingkat komunitas seperti bidan, perawat, dan dokter berperan dalam diagnosis dini, pengobatan, dan rujukan kasus yang membutuhkan perawatan lebih lanjut.

2. Sektor Pendidikan

Keterlibatan sektor pendidikan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pelatihan dan penyuluhan tentang pentingnya gizi, imunisasi, kebersihan, serta tanda bahaya penyakit pada balita. Program ini dapat diterapkan melalui sekolah, pusat komunitas, dan media lokal.

3. Sektor Sosial dan Ekonomi

Keterlibatan sektor sosial dan ekonomi mencakup program bantuan pangan, peningkatan sanitasi, dan dukungan finansial bagi keluarga rentan untuk memastikan akses terhadap layanan kesehatan.

4. Organisasi Non-Pemerintah (NGO)

Banyak NGO mendukung implementasi MTBS dengan menyediakan pelatihan bagi petugas kesehatan, menyuplai obat-obatan esensial, dan melaksanakan survei kesehatan masyarakat untuk memantau efektivitas program.

5. Komunitas Lokal

Partisipasi masyarakat dalam MTBS sangat penting. Komunitas dapat membantu mengenali dan melaporkan

kasus balita sakit, serta mendukung program seperti Posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin (Gera et al., 2016).

Tantangan dalam Kolaborasi Multisektoral (Vhuromu et al., 2022).

1. Kurangnya koordinasi antara sektor-sektor terkait.
2. Keterbatasan sumber daya manusia dan dana di tingkat lokal.
3. Tantangan budaya yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Kolaborasi multisektoral merupakan komponen esensial dalam upaya memperkuat sistem kesehatan di negara berkembang. Pendekatan ini mencakup tidak hanya pengobatan medis, tetapi juga aspek-aspek sosial yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat, seperti kemiskinan, pendidikan, akses air bersih, dan ketahanan pangan. Keberhasilan kolaborasi multisektoral membutuhkan beberapa elemen utama:

1. Kebijakan lintas sektor yang terintegrasi untuk menciptakan kerangka kerja yang solid.
2. Sumber daya bersama, seperti pembiayaan dan tenaga kerja yang memadai.
3. Komunikasi yang efektif antara para pemangku kepentingan untuk memastikan koordinasi yang optimal.
4. Prioritas dalam Kolaborasi Multisektoral berupa pengembangan kebijakan yang mendukung integrasi lintas sektor, peningkatan koordinasi antar sektor, serta evaluasi dampak program multisektoral terhadap kesehatan masyarakat. Adapun Hambatan Kolaborasi Multisektoral.
5. Tantangan yang dihadapi termasuk perbedaan tujuan antar sektor, kurangnya insentif untuk bekerja sama, dan

keterbatasan dalam berbagi data. Penulis juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan antar sektor sebagai dasar kolaborasi yang kokoh.

6. Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Kolaborasi
Membentuk mekanisme koordinasi formal, seperti platform lintas sektor.
7. Mengikutsertakan masyarakat sebagai mitra aktif dalam pelaksanaan program. Memadukan agenda kesehatan ke dalam perencanaan strategis sektor lainnya (Bhutta et al., 2013).

Manfaat Kolaborasi Multisektoral adalah menyediakan solusi jangka panjang untuk masalah kesehatan yang kompleks, seperti malnutrisi, penyakit menular, dan tantangan lingkungan. Program lintas sektor yang terkoordinasi dapat meningkatkan hasil kesehatan sekaligus memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya (Glandon et al., 2018).

Kemitraan lintas sektor di bidang kesehatan mencakup kerjasama antara organisasi kesehatan, pemerintah, sektor swasta, komunitas, dan lembaga non-pemerintah. Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi determinan sosial kesehatan yang kompleks, termasuk lingkungan, pendidikan, pekerjaan, dan gaya hidup masyarakat. Kolaborasi multisektoral dapat menciptakan sinergi yang memperluas cakupan dan efektivitas program kesehatan, dengan menggabungkan kekuatan unik dari setiap sektor untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif. Kepercayaan dan Komunikasi Efektif
Membangun kepercayaan antara mitra lintas sektor merupakan komponen kunci untuk keberhasilan. Komunikasi yang terbuka dan transparan membantu mengelola harapan dan menyelesaikan konflik yang

mungkin muncul selama pelaksanaan program. Kepemimpinan yang efektif diperlukan untuk memfasilitasi koordinasi antar mitra, memastikan akuntabilitas, dan menjaga momentum program. Dukungan dalam bentuk dana, tenaga kerja, dan infrastruktur dari berbagai sektor memungkinkan pelaksanaan program yang lebih luas dan berkelanjutan (Woulfe et al., 2010).

Efektivitas Program Kesehatan: Kolaborasi lintas sektor membantu menciptakan intervensi yang lebih relevan dan tepat sasaran dengan mempertimbangkan berbagai determinan sosial kesehatan. Peningkatan Kapasitas Lokal: Kemitraan ini memperkuat kapasitas komunitas untuk menghadapi tantangan kesehatan secara mandiri. Inovasi dalam Penyelesaian Masalah: Dengan melibatkan berbagai perspektif, kemitraan ini mendorong inovasi dalam desain dan pelaksanaan program kesehatan. Adapun Tantangan dalam Implementasi: (Woulfe et al., 2010):

1. Perbedaan Prioritas Antar Sektor:

Setiap sektor mungkin memiliki tujuan yang berbeda, sehingga membutuhkan kompromi yang bijaksana.

2. Kurangnya Mekanisme Koordinasi:

Tanpa struktur koordinasi yang jelas, kolaborasi dapat menjadi tidak efektif.

3. Keterbatasan Sumber Daya:

Keterbatasan pendanaan dan tenaga kerja dapat menjadi hambatan signifikan dalam mempertahankan kemitraan multisektoral.

4. Rekomendasi untuk Penguatan Kolaborasi

5. Mengintegrasikan Kolaborasi dalam Kebijakan

Penulis merekomendasikan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus secara eksplisit memasukkan kolaborasi multisektoral ke dalam kebijakan kesehatan masyarakat.

6. Membangun Kapasitas untuk Kerjasama

Pelatihan dan pendampingan harus diberikan untuk membangun keterampilan kerjasama lintas sektor.

7. Evaluasi Berbasis Bukti

Melakukan evaluasi hasil program untuk memastikan dampak positifnya dan memperbaiki kelemahan (Basaleem & Amin, 2011).

BAB 5

PENUTUP

Strategi manajemen terpadu balita sakit adalah pendekatan menyeluruh yang bertujuan memberikan perawatan yang lengkap untuk balita yang sedang sakit. Pendekatan ini menggabungkan berbagai elemen, mulai dari diagnosis dan perawatan medis, hingga pemberdayaan keluarga dan pencegahan, yang merupakan faktor kunci untuk mencapai hasil kesehatan anak yang optimal. Fokus utama dari strategi ini adalah kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial, serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal.

Melalui buku kami menggarisbawahi bahwa dalam menyukseskan manajemen terpadu balita sakit diperlukan upaya holistik dengan pendekatan keluarga. Dengan meningkatkan pengetahuan ibu balita, konseling, peran petugas kesehatan serta kolaborasi multisektoral merupakan langkah krusial yang merupakan pondasi untuk meningkatkan kesehatan balita.

Dalam pelaksanaannya, MTBS tidak hanya bergantung pada tenaga medis, tetapi juga melibatkan keluarga dan masyarakat sebagai mitra penting dalam proses penyembuhan dan pencegahan penyakit. Selain itu, adanya kebijakan yang mendukung, pelatihan bagi tenaga kesehatan, serta akses yang setara terhadap layanan kesehatan menjadi landasan yang memastikan kelangsungan program ini.

Keberhasilan pendekatan ini tidak hanya diukur dari angka kesembuhan, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup anak, serta pemberdayaan keluarga dalam mendukung

kesehatan anak. Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan Tenaga Kesehatan.

Agar MTBS dapat diterapkan dengan baik, penting untuk memberikan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan. Pelatihan ini harus berbasis bukti dan mencakup manajemen penyakit pada balita, keterampilan komunikasi, serta teknik pemberdayaan keluarga. Tenaga kesehatan harus dipersiapkan dengan pengetahuan yang memadai mengenai penyakit yang sering menyerang balita, serta cara melibatkan keluarga dalam pengelolaan kesehatan anak.

Pendekatan keluarga dalam Manajemen Kesehatan Balita melalui Pemberdayaan keluarga perlu terus didorong, karena keluarga merupakan pihak utama dalam merawat balita yang sakit. Program pendidikan untuk orang tua dan pengasuh tentang gejala penyakit, pentingnya gizi, dan pemahaman tentang pengobatan yang tepat dapat mempercepat proses penyembuhan dan mencegah komplikasi. Keluarga yang memiliki informasi yang cukup akan lebih siap memberikan perawatan yang efektif dan mendukung pemulihan anak. Pendekatan Holistik dan Multisektoral. Kerja sama antara sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial perlu diperkuat untuk membangun sistem yang lebih efisien dan terintegrasi. Program kesehatan yang melibatkan berbagai sektor, seperti peningkatan gizi, edukasi kesehatan, dan penyediaan fasilitas sanitasi, dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan anak secara menyeluruh.

Peningkatan Akses dan Infrastruktur Kesehatan Beberapa daerah masih menghadapi keterbatasan dalam akses ke layanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, penting untuk memastikan distribusi tenaga kesehatan yang merata dan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil. Pemerintah perlu

mengalokasikan dana yang cukup untuk infrastruktur kesehatan agar dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk balita.

Evaluasi harus dilakukan oleh pemegang program untuk memastikan efektivitas strategi IMAI, diperlukan evaluasi berkala dan penelitian berbasis bukti yang dapat mengukur dampaknya terhadap kesehatan balita. Penelitian lebih lanjut juga penting untuk menilai keberlanjutan dan tantangan dalam penerapan MTBS di berbagai konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Temuan dari penelitian ini dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Dalam menghadapi tantangan kesehatan balita yang kompleks, integrasi strategi manajemen terpadu balita sakit menjadi jawaban yang holistik dan strategis. Pendekatan ini tidak hanya menggabungkan pengobatan medis, tetapi juga melibatkan upaya pencegahan, promosi kesehatan, dan perbaikan determinan sosial yang memengaruhi kesejahteraan anak. Dengan sinergi lintas sektor, kita dapat memperkuat sistem kesehatan, meningkatkan akses, dan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan terbaik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Keberhasilan implementasi strategi ini memerlukan komitmen bersama dari berbagai pemangku kepentingan: tenaga kesehatan di garis depan, pembuat kebijakan, komunitas, dan keluarga. Pendidikan dan pemberdayaan keluarga adalah pilar utama, karena keluarga adalah lingkungan pertama dan terpenting dalam kehidupan seorang anak. Dalam buku ini kami menyimpulkan bahwa integrasi ini sebagai simbol kemajuan kolektif kita dalam memahami bahwa kesehatan anak bukan hanya urusan medis, tetapi juga tanggung jawab sosial yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara

konsisten, kita bukan hanya menyelamatkan nyawa anak-anak, tetapi juga membuka jalan bagi generasi yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi tantangan dunia masa depan. Langkah ini adalah sebuah undangan untuk terus bergerak maju—melampaui pendekatan tradisional menuju solusi yang benar-benar menyeluruh. Bersama, kita dapat memastikan bahwa setiap anak tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan mencapai potensi penuhnya. Kesehatan balita adalah investasi terbesar kita untuk menciptakan dunia yang lebih baik.

Penting untuk memahami bahwa keberhasilan strategi ini tidak hanya dilihat dari angka kesembuhan, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup anak, serta penguatan ketahanan dan peran keluarga dalam mendukung kesehatan anak.

Rekomendasi:

1. Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan Tenaga Kesehatan

Salah satu kunci sukses dari IMAI adalah kesiapan tenaga kesehatan dalam menerapkan pendekatan terpadu ini. Oleh karena itu, pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis bukti mengenai manajemen balita sakit, termasuk keterampilan komunikasi dan pemberdayaan keluarga, harus menjadi prioritas. Tenaga kesehatan perlu dilengkapi dengan pengetahuan yang memadai tentang penyakit yang umum pada balita, serta cara melibatkan keluarga dalam pengelolaan kesehatan anak.

2. Peran Keluarga dalam Manajemen Kesehatan Balita

Pemberdayaan keluarga harus terus ditingkatkan, karena keluarga adalah sumber daya utama dalam merawat balita yang sakit. Program pendidikan bagi orang tua dan pengasuh tentang tanda-tanda penyakit, pentingnya gizi, serta pemahaman tentang pengobatan yang tepat dapat

mempercepat pemulihan dan mencegah komplikasi. Keluarga yang terinformasi akan lebih siap memberikan perawatan yang efektif dan mendukung proses pemulihan anak.

3. Pendekatan Holistik dan Multisektoral:

Kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial harus terus ditingkatkan untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan terintegrasi. Program kesehatan yang melibatkan berbagai sektor, seperti peningkatan gizi, penyuluhan kesehatan, dan akses terhadap fasilitas sanitasi, dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan balita secara menyeluruh.

4. Peningkatan Akses dan Infrastruktur Kesehatan

Di beberapa daerah, akses ke layanan kesehatan berkualitas masih terbatas. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih untuk memastikan distribusi tenaga kesehatan yang merata dan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk infrastruktur kesehatan yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk balita.

5. Evaluasi dan Penelitian Lanjutan:

Untuk memastikan efektivitas dari strategi MTBS, diperlukan evaluasi rutin dan penelitian berbasis bukti yang dapat mengukur dampaknya terhadap kesehatan balita. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menilai keberlanjutan dan tantangan dalam implementasi MTBS di berbagai konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Temuan dari penelitian ini akan sangat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pembaca yang telah mengikuti pembahasan dalam buku ini. Semoga

informasi dan wawasan yang disampaikan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi Anda dan keluarga serta menjadi amal ibadah buat kami Amin Yaa Rabbal Alamin...

DAFTAR PUSTAKA

- Ababa, A. (2019). *Institutionalizing integrated community case management (iCCM) to end preventable child deaths* (Issue July).
- Azriful, A., Adnan, Y., & ... (2021). Implementation of Promotive and Preventive Management Functions for Acute Respiratory Infections in Toddler. ... *Hospital Management* ..., 2(1). <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/homesjournal/article/view/18397%0Ahttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/homesjournal/article/view/18397/10825>
- Basaleem, H. O., & Amin, R. M. (2011). Integrated Management of Childhood Illness in Lahej, Yemen: A qualitative analysis from the perspective of health providers. *Eastern Mediterranean Health Journal*, 17(2), 101–108. <https://doi.org/10.26719/2011.17.2.101>
- Bhutta, Z. A., Das, J. K., Rizvi, A., Gaffey, M. F., Walker, N., Horton, S., Webb, P., Lartey, A., & Black, R. E. (2013). Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: What can be done and at what cost? *The Lancet*, 382(9890), 452–477. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60996-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60996-4)
- Black, R. E., Taylor, C. E., Arole, S., Bang, A., Bhutta, Z. A., Chowdhury, A. M. R., Kirkwood, B. R., Kureshy, N., Lanata, C. F., Phillips, J. F., Taylor, M., Victora, C. G., Zhu, Z., & Perry, H. B. (2017). Comprehensive review of the evidence regarding the effectiveness of community-based primary health care in improving maternal, neonatal and child health: 8.

summary and recommendations of the expert panel. *Journal of Global Health*, 7(1). <https://doi.org/10.7189/jogh.07.010908>

- Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., Bhutta, Z. A., Christian, P., De Onis, M., Ezzati, M., Grantham-Mcgregor, S., Katz, J., Martorell, R., & Uauy, R. (2013). Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *The Lancet*, 382(9890), 427–451. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60937-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60937-X)
- Bryce, J., Boschi-pinto, C., Shibuya, K., Black, R. E., & WHO Child Health Epidemiology Reference Group. (2005). WHO estimates of global causes of death in children. *Lancet*, 365, 1147–1152.
- Bryce, J., Victora, C. G., Habicht, J., Black, R. E., Scherpbier, R. W., Behalf, O. N., The, O. F., & Advisors, M. T. (2005). *Programmatic pathways to child survival: results of a multi-country evaluation of Integrated Management of Childhood Illness*. <https://doi.org/10.1093/heapol/czi055>
- Caron, J., & Markusen, J. R. (2016). *Tantangan Implementasi Kebijakan MTBS*. 1–23.
- Dembo, R. (n.d.). *An Innovative Service for High-Risk Youths " F*.
- Department of Child and Adolescent Health. (2008). *Integrated Management of Childhood Illness chart booklet*. 17(17 2), 36.
- Gera, T., Shah, D., Garner, P., Richardson, M., & Hs, S. (2016). *Integrated management of childhood illness (IMCI) strategy for children under five (Review)*. *Imci*.

<https://doi.org/10.1002/14651858.CD010123.pub2>.
www.cochranelibrary.com

- Glandon, D., Meghani, A., Jessani, N., Qiu, M., & Bennett, S. (2018). Identifying health policy and systems research priorities on multisectoral collaboration for health in low-income and middle-income countries. *BMJ Global Health*, 3, 1–14. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2018-000970>
- Graves, K. N., & Shelton, T. L. (2007). Family empowerment as a mediator between family-centered systems of care and changes in child functioning: Identifying an important mechanism of change. *Journal of Child and Family Studies*, 16(4), 556–566. <https://doi.org/10.1007/s10826-006-9106-1>
- Hanafiah, N. (2022). *CHILDREN ' S SOCIAL COMPETENCES : AN EARLY*.
- Jackson, S. F., Perkins, F., Khandor, E., Cordwell, L., Hamann, S., & Buasai, S. (2006). Integrated health promotion strategies: a contribution to tackling current and future health challenges. *Health Promotion International*, 21 Suppl 1, 75–83. <https://doi.org/10.1093/heapro/dal054>
- Kalu, N., Lufesi, N., Havens, D., & Mortimer, K. (2016). Implementation of world health organization Integrated Management of Childhood Illnesses (IMCI) guidelines for the assessment of pneumonia in the under 5s in Rural Malawi. *PLoS ONE*, 11(5), 1–7. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0155830>
- Kemenkes RI. (2023). Rencana Aksi Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit. *Rencana AKSI Program*

- P2P, 86. <http://www.jikm.unsri.ac.id/index.php/jikm>
- kementerian kesehatan. (2020). *peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian kesehatan tahun 2024*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2015). *Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. 41.
- Ma, S., Frick, K. D., Crawford, A., & Guyer, B. (2015). Early childhood health promotion and its life course health consequences. *Health and Education in Early Childhood: Predictors, Interventions, and Policies*, 9(3), 113–144. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139814805.010>
- Mardhiyah, A., Panduragan, S. L., & Mediani, H. S. (2022). Reducing Psychological Impacts on Children with Chronic Disease via Family Empowerment: A Scoping Review. *Healthcare (Switzerland)*, 10(10), 1–11. <https://doi.org/10.3390/healthcare10102034>
- Mitra, M., Karnawati, R., Marlina, H., Rany, N., & ... (2024). The Performance Of Integrated Healthcare Center Cadres In The Toddler Early Development Intervention Detection Stimulation Program. ... *International Journal of ...* <https://jurnal.http.ac.id/index.php/miracle/article/view/1843%0Ahttps://jurnal.http.ac.id/index.php/miracle/article/download/1843/629>
- Monsen, R. B. (2005). Improving child health. In *Journal of Pediatric Nursing* (Vol. 20, Issue 4, pp. 285–286). <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2005.06.013>

- Natalianingsih, N. (2018). *Optimizing the Growth of Toddler Through Nutrition Counseling*. 12(Isphe), 49–53. <https://doi.org/10.2991/isphe-18.2018.11>
- Nutbeam, D., & Muscat, D. M. (2021). Health Promotion Glossary 2021. *Health Promotion International*, 36(6), 1578–1598. <https://doi.org/10.1093/heapro/daaa157>
- Perry, H. B., & Hodgins, S. (2021). Health for the people: Past, current, and future contributions of national community health worker programs to achieving global health goals. *Global Health Science and Practice*, 9(1), 1–9. <https://doi.org/10.9745/GHSP-D-20-00459>
- Pinto, J, Puspitasari, Y., & Peristiowati, Y. (2024). Strategi Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat. In *Penerbit Tahta Media*. <http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/706%0Ahttps://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/download/706/715>
- Pinto, Joaquim, Jesus, A. De, Noronha, H., Belo, S., Nacional, U., & Loro, T. (2024). *Through Health Promotion Strategies Peran Kearifan Lokal dalam Menurunkan Angka Morbiditas dan Mortalitas Balita Melalui Strategi Promosi Kesehatan*. 1(2), 202–221.
- Pitchik, H. O., Tofail, F., Rahman, M., Akter, F., Sultana, J., Shoab, A. K., Huda, T. M. N., Jahir, T., Amin, M. R., Hossain, M. K., Das, J. B., Chung, E. O., Byrd, K. A., Yeasmin, F., Kwong, L. H., Forsyth, J. E., Mridha, M. K., Winch, P. J., Luby, S. P., & Fernald, L. C. H. (2021). A holistic approach to promoting early child development: A

cluster randomised trial of a group-based, multicomponent intervention in rural Bangladesh. *BMJ Global Health*, 6(3), 1–13. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-004307>

Rahmah, R., & Astuti, Y. (2021). The implementation of integrated management of children illness in primary health community in yogyakarta, indonesia. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9(T4), 315–318. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.5808>

Robert E Black, Saul S Morris, J. B. (2003). Only reproduce with permission from The Lancet. Risk factors for child mortality Underlying causes of death. *Lancet*, 361, 2226–2234.

Schulman, K., & Analyst, S. P. (2011). Promising state child care quality and infant/toddler initiatives. *Initiatives*, 5185(April).

Siti Suciati. (2023). Pemberdayaan Keluarga dalam Terapi Batuk Pilek tanpa Obat pada Anak. *Janita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 51–55. <https://doi.org/10.36563/pengabdian.v2i2.581>

Sreeramareddy, C., Sathyanarayana, T., Anchala, R., & Kumar, H. H. (2015). PROTOCOL: Family and Community Interventions under Integrated Management of Childhood Illness Strategy for Reduction of Neonatal and Under-five Mortality among Children in Low-And-Middle-Income Countries: A Systematic Review. *Campbell Systematic Reviews*, 11(1), 1–50. <https://doi.org/10.1002/cl2.147>

Sudirman, A. A., & Ali, L. (2019). Penerapan Manajemen

- Terpadu Balita Sakit (Mtbs) Di Puskesmas Kota Gorontalo. *Jurnal Zaitun*, 3(1), 13–18.
- Sukarto, R. C. W., Ismanto, A. Y., & Karundeng, M. y. (2016). Hubungan Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Ispa Dengan Kekambuhan Ispa Pada Balita Di Puskesmas Bilalang Kota Kotamobagu. *E-Keperawatan (e-Kp)*, 4(1), 1–6.
- Unicef. (2018). *EVERY CHILD ALIVE The urgent need to end newborn deaths*.
- Vhuromu, T., Gonzalez, G., & Davhana-Maselesele, B. (2022). Integrated Management Of Childhood Illness (IMCI): Planning, Implementing and Evaluating Pre-Service Training. *International Journal of Quality in Health Care*, 48(8), 227–236.
- WHO. (2018). *Integrating palliative care and symptom relief into paediatrics: a WHO guide for health care planners, implementers and managers*.
- Woulfe, J., Oliver, T. R., Zahner, S. J., & Siemering, K. Q. (2010). Multisector partnerships in population health improvement. *Preventing Chronic Disease*, 7(6).
- Yeh, H. Y., Ma, W. F., Huang, J. L., Hsueh, K. C., & Chiang, L. C. (2016). Evaluating the effectiveness of a family empowerment program on family function and pulmonary function of children with asthma: A randomized control trial. *International Journal of Nursing Studies*, 60, 133–144. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2016.04.013>

GLOSARIUM

A

Antropometri: Ilmu yang mempelajari pengukuran tubuh manusia, seperti tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala, untuk menilai status gizi.

Anemia: Kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin, sering disebabkan oleh kekurangan zat besi pada balita.

B

Balita: Anak usia di bawah lima tahun yang menjadi fokus utama dalam program kesehatan ibu dan anak.

Breastfeeding: Praktik memberikan ASI eksklusif kepada bayi selama enam bulan pertama kehidupan untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan optimal.

C

Cakupan Imunisasi: Persentase populasi balita yang menerima imunisasi sesuai jadwal untuk melindungi dari penyakit tertentu.

Cacingan: Infeksi yang disebabkan oleh cacing parasit, sering terjadi pada balita akibat sanitasi yang buruk.

D

Diare: Penyakit yang ditandai dengan buang air besar lebih dari tiga kali sehari dengan konsistensi cair, yang dapat menyebabkan dehidrasi pada balita.

Dehidrasi: Kondisi akibat kehilangan cairan tubuh yang berlebihan, sering terjadi akibat diare atau muntah.

E

Elektrolit: Mineral penting dalam tubuh seperti natrium dan kalium yang membantu menjaga keseimbangan cairan.

Edukasi Kesehatan: Upaya memberikan informasi kepada orang tua atau pengasuh balita untuk meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan dan penanganan penyakit.

G

Gizi Buruk: Kondisi kurangnya asupan gizi yang memadai, menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada balita.

Gizi Seimbang: Konsep pemberian makanan dengan kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral sesuai kebutuhan tubuh balita.

H

Holistik:

Pendekatan yang melihat dan menangani masalah secara menyeluruh, mencakup berbagai aspek seperti fisik, mental, sosial, dan lingkungan.

I

IMCI (Integrated Management of Childhood Illness): Strategi terpadu untuk mengelola penyakit pada balita dengan pendekatan holistik.

Imunisasi: Proses pemberian vaksin untuk mencegah penyakit infeksi seperti polio, campak, dan hepatitis B pada balita.

Integrasi Strategi Manajemen Terpadu Balita Sakit:
Langkah Holistik Bagi Kesehatan Balita

Integrasi: Pendekatan yang menggabungkan berbagai komponen, metode, atau layanan secara menyeluruh untuk mencapai hasil yang optimal.

K

Kunjungan Kesehatan: Pemeriksaan rutin ke fasilitas kesehatan untuk memantau pertumbuhan, perkembangan, dan status kesehatan balita.

Kekurangan Zat Besi: Salah satu penyebab utama anemia yang sering terjadi pada balita akibat kurangnya konsumsi makanan kaya zat besi.

M

Malaria: Penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium, ditularkan melalui gigitan nyamuk, sering menyerang balita di daerah endemis.

Malnutrisi: Kondisi kekurangan atau kelebihan gizi yang memengaruhi kesehatan dan perkembangan anak.

P

Pneumonia: Infeksi saluran pernapasan yang sering menyerang paru-paru balita, menyebabkan kesulitan bernapas dan membutuhkan penanganan segera.

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu): Tempat pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa yang fokus pada ibu dan balita.

S

Stunting: Masalah kronis pertumbuhan pada balita akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang, ditandai dengan tinggi badan yang rendah untuk usia.

Sanitasi: Upaya menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah penyakit pada balita.

Strategi:

Rencana atau pendekatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu.

V

Vaksinasi: Proses pemberian vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh balita terhadap penyakit tertentu.

Vitamin A: Nutrisi penting yang diberikan kepada balita untuk mendukung kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh.

Z

Zinc: Mineral penting untuk mendukung pertumbuhan balita dan mempercepat pemulihan dari diare

PROFIL PENULIS



Sri Rosita, S.KM., M.K.M., Penulis lahir di Air Sialang Tengah, Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 02 Maret 1990. Penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Serambi Mekkah. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan dan melanjutkan S2 di Universitas Sumatera Utara Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan konsentrasi yang sama. Adapun beberapa mata kuliah yang diampu diantara Dasar Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Ekonomi dan Pembiayaan Kesehatan, Metoda Analisis Kebijakan Kesehatan, Advokasi Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan, Manajemen Pemasaran Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional dll. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, dan seminar nasional. penulis antara lain dapat dihubungi melalui email: srirosita@serambimekkah.ac.id

PROFIL PENULIS



Rahmayani, S.KM., M.Kes., merupakan salah satu dosen tetap peminatan Epidemiologi Universitas Serambi Mekkah. Penulis menempuh pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Aceh, dan melanjutkan study S2 nya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Peminatan Epidemiologi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, dan seminar nasional. penulis antara lain dapat dihubungi melalui email: rahmayani@serambimekkah.ac.id

Evi Dewi Yani, S.KM., M.Kes., Lahir di Langsa, 10 Oktober 1987. Penulis menempuh pendidikan S1 FKM Universitas Muhammadiyah Aceh dan melanjutkan pendidikan S2 di FKM Universitas Sumatera Utara. Penulis merupakan salah satu dosen tetap peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, dan seminar nasional. penulis antara lain dapat dihubungi melalui email: rahmayani@serambimekkah.ac.id

PROFIL PENULIS



Yunita, S.Pd., M.Pd., Lahir di Aceh Barat, 7 Maret 1984. Pendidikan yang telah di tempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program studi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Serambi Mekkah Aceh pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan Pendidikan S2 pada Universitas Syiah Kuala dan lulus pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan di awali pada tahun 2018 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Serambi Mekkah. Saat ini penulis bekerja di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Serambi Mekkah mengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar dan melakukan penelitian serta pengabdian Masyarakat. Penulis dapat di hubungi melalui yuniita006gmail.com

PROFIL PENULIS



Dr. Tika Indiraswari, S.Si., M.Kes.,

Lahir di Surabaya, 12 Januari 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Biologi, FMIPA Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2001. Kemudian menempuh pendidikan S2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan di FKM Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2012. Tahun 2018 hingga tahun 2023 penulis menempuh pendidikan pada Program Studi S3 Kesehatan Masyarakat, FKM Universitas Airlangga, Surabaya. Riwayat pekerjaan penulis sebagai staf Humas dan Pemasaran di RSI Siti Aisyah Madiun, Jawa Timur tahun 2012-2013. Penulis bekerja sebagai peneliti PECAPP (Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program) Universitas Syiah Kuala-Bank Dunia- Pemerintah Provinsi Aceh tahun 2013-2014. Tahun 2015 penulis bekerja sebagai dosen di FKM Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh hingga saat ini, mengampu mata kuliah One Health, Current Isu AKK, Advokasi Kesehatan, dan Biostatistika Dasar. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, melakukan penelitian dalam bidang kesehatan masyarakat, serta melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui email: tikaindiraswari@serambimekkah.ac.id.

SINOPSIS BUKU

Buku ini menyajikan pendekatan holistik dan terintegrasi dalam pengelolaan kesehatan balita, dengan menekankan pentingnya menerapkan strategi-strategi manajemen terpadu balita sakit (MTBS). Menghadapi berbagai tantangan kesehatan pada balita, seperti infeksi, malnutrisi, dan gangguan pertumbuhan, buku ini mengajak pembaca untuk melihat kesehatan balita dari sudut pandang yang lebih luas, melibatkan aspek pencegahan, pemberdayaan keluarga, pendidikan kesehatan, serta keterlibatan berbagai sektor.

Buku ini juga menekankan bahwa keberhasilan dalam meningkatkan kesehatan balita tidak hanya bergantung pada pengobatan medis, tetapi juga pada faktor-faktor pendukung lainnya, seperti konseling, peran petugas, meningkatkan pengetahuan ibu balita, keterlibatan aktif keluarga, serta sistem kesehatan yang efisien dan terintegrasi. Kerja sama lintas sektor melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial ditekankan sebagai kunci menciptakan lingkungan yang lebih mendukung kesehatan balita. Dalam buku ini, pembaca akan menemukan teori dasar mengenai manajemen kesehatan anak beserta aplikasinya dalam program kesehatan yang melibatkan keluarga dan masyarakat.

Setiap bab dalam buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kolaborasi antar sektor dan peran utama keluarga dalam mendukung kesehatan anak. Dari edukasi orang tua tentang gizi, kebersihan, hingga perawatan dasar, serta peningkatan akses layanan kesehatan yang merata, buku ini menawarkan

solusi praktis dan strategi yang dapat diterapkan. Buku ini akan menjadi panduan yang sangat berharga bagi siapa saja yang ingin berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup balita.

Buku ini menyajikan pendekatan holistik dan terintegrasi dalam pengelolaan kesehatan balita, dengan menekankan pentingnya menerapkan strategi-strategi manajemen terpadu balita sakit (MTBS). Menghadapi berbagai tantangan kesehatan pada balita, seperti infeksi, malnutrisi, dan gangguan pertumbuhan, buku ini mengajak pembaca untuk melihat kesehatan balita dari sudut pandang yang lebih luas, melibatkan aspek pencegahan, pemberdayaan keluarga, pendidikan kesehatan, serta keterlibatan berbagai sektor.

Buku ini juga menekankan bahwa keberhasilan dalam meningkatkan kesehatan balita tidak hanya bergantung pada pengobatan medis, tetapi juga pada faktor-faktor pendukung lainnya, seperti konseling, peran petugas, meningkatkan pengetahuan ibu balita, keterlibatan aktif keluarga, serta sistem kesehatan yang efisien dan terintegrasi. Kerja sama lintas sektor melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial ditekankan sebagai kunci menciptakan lingkungan yang lebih mendukung kesehatan balita. Dalam buku ini, pembaca akan menemukan teori dasar mengenai manajemen kesehatan anak beserta aplikasinya dalam program kesehatan yang melibatkan keluarga dan masyarakat.

Setiap bab dalam buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kolaborasi antar sektor dan peran utama keluarga dalam mendukung kesehatan anak. Dari edukasi orang tua tentang gizi, kebersihan, hingga perawatan dasar, serta peningkatan akses layanan kesehatan yang merata, buku ini menawarkan solusi praktis dan strategi yang dapat diterapkan. Buku ini akan menjadi panduan yang sangat berharga bagi siapa saja yang ingin berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup balita.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7097-98-9



9

786347

097989